SUPORTE SOCIAL						
Você é capaz de ler e escrever?	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
Beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou Bolsa Família	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
Moradia própria	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
Moradia em boas condições de organização e higiene	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
Acesso a renda própria ou de familiares próximos, suficiente para garantir a própria subsistência	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
Relato de participação em alguma atividade extradomiciliar ou comunitária ou rede social, como trabalho, família, igreja, grupo de convivência etc	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO

Adaptado de SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN. Nota técnicapara a organização da Rede de Atenção à Saúde com foco na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Ambulatorial Especializada: saúde da pessoa idosa. São Paulo: Hospital Israelita Albert Einstein: Ministério da Saúde, 2019.

AVALIAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

DATA DA AVALIAÇÃO:					
HÁBITOS	Álcool	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
	Fumo	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
ALTERAÇÕES OU LESÕES DE MUCOSA	Presença de lesão na mucosa bucal	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
	Boca seca (xerostomia – falta de saliva)	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
	Presença de língua saburrosa (língua branca)	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
	Presença de candidíase bucal	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
	Presença de halitose	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
CÁRIE DENTÁRIA E DOENÇA PERIODONTAL	Presença de placa bacteriana (biofilme dental)	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
	Fatores retentivos de placa (raízes residuais, cálculo)	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
	Presença evidente de gengivite/ sangramento gengival	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
	Presença evidente de periodontite/ perda óssea	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
	Presença de cárie	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
	Perda dental no último ano	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO

PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR	☐ Prótese total (dentadura) ☐ Prótese parcial (ponte móvel)	NÃO UTILIZA E NÃO NECESSITA	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
		NÃO UTILIZA, MAS NECESSITA	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
		UTILIZA – ADAPTADA/ SEM NECESSIDADE DE TROCA	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
		UTILIZA – NÃO ADAPTADA/NECESSITA DE TROCA	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
PRÓTESE DENTÁRIA INFERIOR	☐ Prótese total (dentadura) ☐ Prótese parcial (ponte móvel)	NÃO UTILIZA E NÃO NECESSITA	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
		NÃO UTILIZA, MAS NECESSITA	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
		UTILIZA – ADAPTADA/ SEM NECESSIDADE DE TROCA	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
		UTILIZA – NÃO ADAPTADA/NECESSITA DE TROCA	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO

CONSULTA CLÍNICA (EQUIPE DE SAÚDE BUCAL)	(U) Atendimento da unidade de saúde (D) Atendimento domiciliar				
ENCAMINHAMENTO PARA ESPECILIDADES ODONTOLÓGICAS	(D) Diagnóstico bucal (P) Periodontia (E) Endodontia (C) Cirurgia (PCD) Pessoa com deficiência (O) Outras especialidades				

HISTÓRICO DE EXAMES LABORATORIAIS

EXAMES LABORATORIAIS	DATA	RESULTADO	DATA	RESULTADO	DATA	RESULTADO

06 HISTÓRICO – OUTROS EXAMES OU INFORMAÇÕES RELEVANTES

REGISTRO DE EXAMES DE IMAGEM, LAUDOS OU OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES	
EXAMES	**RESULTADOS / LAUDOS**

CUIDADO COORDENADO (REFERÊNCIA – CONTRARREFERÊNCIA)

REGISTRO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES DE ATENDIMENTOS NOS DIFERENTES PONTOS DA REDE – SUMÁRIO DE ALTA, REFERÊNCIA OU CONTRARREFERÊNCIA, ENTRE OUTROS	
DATA	**INFORMAÇÕES RELEVANTES**
___/___/_____	
___/___/_____	
___/___/_____	
___/___/_____	
___/___/_____	
___/___/_____	
___/___/_____	
___/___/_____	
___/___/_____	

AGENDA DE ATIVIDADES COLETIVAS

Atividades coletivas, práticas corporais ou atividades de convivência/lazer			
Atividade	**Local em que é realizada**	**Dia/hora**	**Observações**

Autoavaliação do consumo de álcool

Seção	Pergunta	Resposta
Reduzir o consumo	Alguma vez você já sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida que consome?	☐ Sim ☐ Não
Irritação com comentários	Alguém já comentou sobre seu jeito de beber e isso aborreceu você?	☐ Sim ☐ Não
Sentimento de culpa	Já se sentiu culpado ou mal por causa do seu consumo de álcool?	☐ Sim ☐ Não
Começo do dia	Já houve uma manhã em que precisou beber para se sentir melhor ou superar uma ressaca?	☐ Sim ☐ Não

Adaptado e traduzido de Questionário CAGE – Ewing, J. A. (1984). Detecting alcoholism: The CAGE questionnaire. Journal of the American Medical Association, 252(14), 1905-1907.

ALTERAÇÕES NO COMPORTAMENTO

Mudanças rápidas no comportamento de pessoas idosas podem ter várias causas e não acontecem somente por dificuldades de convivência ou problemas mentais. Na verdade, muitas vezes, essas mudanças de comportamento podem estar ligadas a problemas de saúde orgânicos, como **dor, infecções, desidratação e reações adversas a medicamentos.**

Exemplos dessas mudanças são: mudanças no padrão de sono (dormir muito ou dormir muito pouco), episódios de agitação, agressividade, ou até mesmo falar pouco ou não querer comer.

AGENDA DE ATENDIMENTOS

Data	Hora	Local	Profissional

CALENDÁRIO VACINAL

Registro da Aplicação das Vacinas do Calendário Nacional

NOME:						Data de Nascimento: ___/___/_____	
	Influenza					Hepatite B	Dupla Adulto (dT)
	Data: / / Lote: Lab.Produt: Unidade: Ass.:	Data: / / Lote: Lab.Produt: Unidade: Ass.:	Data: / / Lote: Lab.Produt: Unidade: Ass.:	Data: / / Lote: Lab.Produt: Unidade: Ass.:	Data: / / Lote: Lab.Produt: Unidade: Ass.:	Data: / / Lote: Lab.Produt: Unidade: Ass.:	Data: / / Lote: Lab.Produt: Unidade: Ass.:
	Data: / / Lote: Lab.Produt: Unidade: Ass.:	Data: / / Lote: Lab.Produt: Unidade: Ass.:	Data: / / Lote: Lab.Produt: Unidade: Ass.:	Data: / / Lote: Lab.Produt: Unidade: Ass.:	Data: / / Lote: Lab.Produt: Unidade: Ass.:	Data: / / Lote: Lab.Produt: Unidade: Ass.:	Data: / / Lote: Lab.Produt: Unidade: Ass.:
	Covid-19						
	Data: / / Lote: Lab.Produt: Unidade: Ass.:	Data: / / Lote: Lab.Produt: Unidade: Ass.:	Data: / / Lote: Lab.Produt: Unidade: Ass.:	Data: / / Lote: Lab.Produt: Unidade: Ass.:	Data: / / Lote: Lab.Produt: Unidade: Ass.:		
	Data: / / Lote: Lab.Produt: Unidade: Ass.:	Data: / / Lote: Lab.Produt: Unidade: Ass.:	Data: / / Lote: Lab.Produt: Unidade: Ass.:	Data: / / Lote: Lab.Produt: Unidade: Ass.:	Data: / / Lote: Lab.Produt: Unidade: Ass.:		



CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO 2026

Vacinas do Idoso (a partir de 60 anos)

Em todas as idades, as vacinas são essenciais para prevenir doenças graves.

Manter as vacinas em dia é cuidar da saúde. A vacinação promove uma vida saudável e contribui para a qualidade de vida e o bem-estar da pessoa idosa.

Este Calendário orienta sobre as vacinas necessárias para o idoso.

	VACINA	DOSE	DOENÇAS EVITADAS
Conforme histórico vacinal	hepatite B	3 doses	hepatite B, hepatite D
	dT	3 doses + reforços periódicos	difteria, tétano[1]
	febre amarela	1 dose, em casos excepcionais	febre amarela[2]
	tríplice viral SCR	2 doses	sarampo, caxumba, rubéola[3]
	varicela	2 doses	varicela (catapora)[4]
	pneumocócica 20-valente	1 dose	doenças pneumocócicas invasivas[5]
	influenza trivalente	1 dose anual a cada temporada	influenza (gripe)
	covid-19	1 dose semestral	formas graves da covid-19 causadas pelo vírus SARS-CoV-2

[1] 1 dose de reforço a cada 10 anos após a última dose de vacina com componentes toxóides diftérico e tetânico, antecipando para 5 anos em caso de exposição a risco de difteria e tétano. Para profissionais de saúde, parteiras tradicionais e estagiários que atuam com recém-nascidos, recomenda-se a vacina dTpa.

[2] Somente para não vacinados, quando há alto risco de contrair a doença. Isso vale para os residentes e viajantes para área de risco epidemiológico* e deve ser precedido por avaliação pelo serviço de saúde. Para os viajantes, recomenda-se vacinar pelo menos 10 dias antes da viagem.

[3] Somente para trabalhador de saúde com atuação profissional. Recomenda-se atualizar a situação vacinal, precedido por avaliação pelo serviço de saúde.

[4] Somente para trabalhadores da saúde e povos indígenas, sem história da doença ou na dúvida. A vacinação deve ser precedida por avaliação pelo serviço de saúde.

[5] Somente para não vacinados que vivem acamados e/ou institucionalizados (como em casas geriátricas, hospitais, unidades de acolhimento/instituições de longa permanência/casas de repouso) e povos indígenas sem histórico vacinal com pneumocócica conjugada.

---

*Áreas com circulação viral comprovada (casos humanos, epizootia ou potenciais vetores infectados), em contextos de surto, alto risco epidemiológico e emergência em saúde pública.

IDENTIFICAÇÃO

Nome completo:	
Como você gosta de ser chamado(a):	
Data de nascimento: _____/_____/_____	Cole aqui sua foto
CNS:	
CPF:	
Número de Identificação Social (NIS):	
Você está inserido(a) no Cadastro Único? ☐ Sim ☐ Não	
Identidade de Gênero:	
Povos e/ou comunidades tradicionais? ☐ Sim ☐ Não ☐ Quilombola ☐ Indígena ☐ Ribeirinha ☐ Cigana ☐ Outro:_____	
Raça/cor: ☐ Branca ☐ Preta ☐ Parda ☐ Amarela (oriental) ☐ Indígena – especifique o povo/etnia:_____	
Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) de referência:	

Nacionalidade: ☐ Brasileira ☐ Naturalizada ☐ Estrangeira	Naturalidade:
Rua/avenida/praça/quadra:	N.º:
Bairro:	Complemento:
Telefone:	
Qual é sua Unidade Básica de Saúde (UBS)/equipe de Saúde da Família de referência?	
Está vinculado(a) a um Centro de Referência de Assistência Social (Cras)? Qual?	
Tem alguma deficiência? ☐ Sim ☐ Não ☐ Auditiva ☐ Visual ☐ Intelectual ☐ Física ☐ Outra:_____ Especificar:_____ _____	Tem histórico de alergias? Qual?
Grupo sanguíneo/fator Rh:	

O preenchimento dos campos abaixo deve ser a lápis, para serem alterados sempre que necessário.

Sabe ler e escrever? ☐ Sim ☐ Não
Qual foi o nível educacional mais elevado que você frequentou? ☐ Nenhum ☐ Ensino fundamental ☐ Ensino médio/técnico ☐ Educação de Jovens e Adultos ☐ Ensino superior ☐ Pós-graduação
Pratica alguma religião ou espiritualidade? ☐ Sim. Qual?_____ ☐ Não ☐ Prefiro não dizer
Qual é sua ocupação principal?
Tem fonte de renda fixa? ☐ Sim ☐ Não ☐ Salário ☐ Aposentadoria ☐ Pensão ☐ BPC/Loas ou Bolsa Família ☐ Outra:_____
Situação conjugal: ☐ Solteiro(a) ☐ Casado(a)/união estável ☐ Divorciado(a)/separado(a) ☐ Viúvo(a) ☐ Outra:_____
Reside com quem? ☐ Sozinho(a) ☐ Cônjuge ☐ Familiar:_____ ☐ Outro: _____

Reside em: ☐ Casa ☐ Apartamento ☐ Cômodo ☐ Moradia coletiva (Instituição de Longa Permanência de Idosos, Casa-Lar, república para idosos, abrigos) ☐ Em situação de rua ☐ Desabrigado ☐ Em privação de liberdade ☐ Residência terapêutica ☐ Outro:_____
Área: ☐ Urbana ☐ Rural
Imóvel: ☐ Próprio ☐ Alugado ☐ Cedido ☐ Outro:_____

CUIDADOS

Você precisa de cuidados de terceiros para realizar atividades do dia a dia? ☐ Sim ☐ Não
Você tem uma pessoa que cuida de você? ☐ Sim ☐ Não ☐ Cuidador(a) ☐ Familiar ☐ Amigo(a) ☐ Vizinho(a) ☐ Outra:_____
Você é responsável pelo cuidado de alguém? ☐ Sim ☐ Não ☐ Familiar. Qual?_____ ☐ Outro:_____

PESSOAS DE REFERÊNCIA

Você tem pessoas de referência? ☐ Sim ☐ Não

Informe os dados de pessoas que possam ser contatadas em caso de urgência.

O preenchimento dos campos abaixo deve ser a lápis, para serem alterados sempre que necessário.

Nome completo:
Telefone:
Qual é o grau de relação? ☐ Familiar ☐ Vizinho(a) ☐ Amigo(a) ☐ Outro:_____
Essa pessoa mora com você? ☐ Sim ☐ Não

Nome completo:
Telefone:
Qual é o grau de relação? ☐ Familiar ☐ Vizinho(a) ☐ Amigo(a) ☐ Outro:_____
Essa pessoa mora com você? ☐ Sim ☐ Não

Nome completo:
Telefone:
Qual é o grau de relação? ☐ Familiar ☐ Vizinho(a) ☐ Amigo(a) ☐ Outro:_____
Essa pessoa mora com você? ☐ Sim ☐ Não

CALENDÁRIOS

SBIM

SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES

2026|27

V. 19/06/2026

Calendários de vacinação SBIm 2026/2027

SBIm – Sociedade Brasileira de Imunizações

DIRETORIA SBIM

Presidente: Mônica Levi (SP)
Vice-Presidente: Renato Kfouri (SP)
1ª Secretária: Flavia Bravo (RJ)
2ª Secretária: Isabella Ballalai (RJ)
1ª Tesoureira: Mayra Moura (SP)
2º Tesoureiro: Juarez Cunha (RS)

Comissão Técnica para Revisão dos Calendários Vacinais

Presidente: Juarez Cunha (RS)
Membros:
Ana Karolina Barreto Berselli Marinho (SP)
Ana Paula Neves Burian (ES)
Analíria Pimentel (PE)
Claudia França Cavalcante Valente (DF)
Eduardo Jorge da Fonseca Lima (PE)
Eitan Berezin (SP)
Flávia Bravo S. Nascentes da Silva (RJ)
Gabriel Oselka (SP)
Guido Levi (SP)
Heloisa Ihle Garcia Gianberardino (PR)
Isabella Ballalai (RJ)
José Geraldo Leite Ribeiro (MG)
Lauro Ferreira da Silva Pinto Neto (ES)
Lily Yin Weckx (SP)
Marco Aurélio Sáfadi (SP)
Maria Angela Rocha (PE)
Marta Heloisa Lopes (SP)
Mayra Moura (SP)
Melissa Palmieri (SP)
Mônica Levi (SP)
Regina Succi (SP)
Renato Kfouri (SP)
Ricardo Becker Feijó (RS)
Rosana Richtmann (SP)
Solange Dourado (AM)
Sônia Maria de Faria (SC)
Tânia Petraglia (RJ)

Coordenação editorial
Ricardo Machado

Direção de arte e produção gráfica
Silvia Fittipaldi

Capa
Estúdio Magic RM

MAGIC RM **19.06.2026**

A **Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm)** apresenta seus calendários 2026/2027. Neles você encontrará todas as recomendações para a proteção de prematuros, crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e trabalhadores contra as diversas doenças infecciosas preveníveis por vacinas.

Criada em 1998, a SBIm é hoje referência em imunizações, reconhecimento conquistado graças ao trabalho ético e responsável que tem por objetivo a promoção da saúde – parte fundamental de sua missão – por meio da educação e da difusão de conhecimentos significativos da sua área de atuação.

A divulgação dos **Calendários de Vacinação SBIm** faz parte deste esforço, para orientação e atualização dos profissionais da saúde.

Faça bom uso!

SBIm
Sociedade Brasileira de Imunizações
Trabalho e atitude pela vida!

Os calendários SBIm de rotina são elaborados para indivíduos hígidos. Para pacientes especiais, ou em situações epidemiológicas específicas, as recomendações podem ser alteradas.

EVENTOS SUPOSTAMENTE ATRIBUÍVEIS À VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO (ESAVI)

Após o licenciamento de vacinas é realizada vigilância de Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação e Imunização (ESAVI) em todos os países. No Brasil, por meio do Sistema de Informação de Vigilância desses eventos do Programa Nacional de Imunizações (PNI), objetiva-se quantificar e qualificar esses eventos, para garantir que os riscos de complicações graves causadas pelas vacinas sejam nulos ou muito menores que os oferecidos pelas doenças contra as quais elas oferecem proteção. Como qualquer medicamento, as vacinas podem causar reações, mas o risco de eventos graves é pequeno. Para melhor eficiência dessa vigilância é fundamental que o profissional da Saúde notifique todo e qualquer evento grave ou inesperado. Não é necessário ter certeza da associação entre a reação adversa e a vacinação. A simples suspeita da associação é suficiente para se realizar uma notificação.

ESAVI graves são de notificação compulsória imediata (em até 24 horas) para o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE), conforme as recomendações do Ministério da Saúde e a legislação vigente*, sendo que o registro da notificação deve ser realizado no sistema e-SUS Notifica (módulo ESAVI), por meio do link: https://notifica.saude.gov.br/.

Os ESAVI não graves e os erros de imunização podem ser notificados no mesmo sistema, permitindo a detecção e o monitoramento de sinais de segurança, surtos e conglomerados.
Para os desvios de qualidade dos imunobiológicos, a notificação deve ser realizada para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no sistema Notivisa, por meio do link: https://notivisa.anvisa.gov.br/frmLogin.asp

As pessoas vacinadas ou os seus pais/responsáveis podem fazer a auto-notificação de eventos adversos no sistema Vigimed, por meio do link: https://vigiflow-eforms.who-umc.org/br/vigimed.

Para informações mais detalhadas sobre os eventos e suas frequências, consulte a bula de cada vacina, na qual são discriminados os resultados obtidos nos estudos de licenciamento. Consulte também informações sobre vacinas em: ***https://familia.sbim.org.br/vacinas/vacinas-disponiveis*** e no artigo Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação e Imunização (ESAVI): O papel do pediatra na orientação das famílias da Sociedade Brasileira de Pediatria em: ***https://sbim.org.br/images/files/notas-tecnicas/nt-sbp-esavi-papel-pediatra-orientacao-familias.pdf*** (Acessados em: 07 ago. 2023)

OFF LABEL – DEFINIÇÕES E CRITÉRIOS

A Anvisa define o uso *off label* como: "uso em situações divergentes da bula de um medicamento registrado pelo órgão. Pode incluir diferenças na indicação, faixa etária/peso, dose, frequência, apresentação ou via de administração." A Anvisa manifestou, ainda, sua anuência ao uso *off label*. Considera, em sua conclusão, que: "O uso *off label* é, por definição, não autorizado por uma agência reguladora, mas isso não implica que seja incorreto", pois reconhece, neste posicionamento, que a velocidade de ampliação do licenciamento pela Agência pode ser muito inferior ao surgimento de evidências científicas sólidas que justifiquem a ampliação das indicações ou ao licenciamento por órgãos regulatórios de outros países. Já o Código de Ética Médica determina que: "o médico deve usar todos os meios disponíveis de tratamento a seu alcance, em favor do paciente" (art. 32).

Partindo dessas premissas, a Comissão Técnica para Revisão dos Calendários Vacinais e Consensos da SBIm, posiciona-se de modo favorável à recomendação *off label*, quando existem:

1. resultados de estudos pós-licenciamento de segurança e eficácia; e/ou
2. experiências em outros países com a indicação em questão; e/ou
3. licenciamento dessas novas indicações por órgãos regulatórios de outros países; e/ou
4. posicionamento da OMS e/ou do PNI favorável às novas indicações; e/ou
5. quando o risco para determinada infecção se mostra importante para grupos não contemplados em bula; e/ou
6. opinião favorável de *experts* brasileiros e internacionais.

Em nossos calendários estão informadas as recomendações *off label* endossadas pela SBIm, exceto aquelas já consagradas pelo PNI.

ESQUEMAS INICIADOS FORA DA IDADE RECOMENDADA

O número de doses necessárias para induzir a proteção, assim como o intervalo entre elas, pode variar conforme a idade, sendo que os esquemas de vacinação preconizados para as diversas vacinas baseiam-se em resultados de estudos pré-licenciamento feitos nas diferentes faixas etárias.

Quando a vacinação é iniciada fora da idade idealmente recomendada, os esquemas podem sofrer alterações de acordo com a idade de início, sendo necessário consultar a bula da vacina para adequar o calendário, obedecendo aos intervalos mínimos entre as doses.

Atenção para as idades de recomendação das vacinas nos diferentes calendários, pois algumas delas deixam de ser indicadas quando ultrapassada a idade de risco para determinada infecção ou por não existirem estudos de eficácia e segurança em outras idades fora da faixa de recomendação.

Ver Nota Técnica sobre recuperação de doses em atraso:

https://sbim.org.br/calendario-de-vacinacao/esquemas-em-atraso (Acesso em 19/06/2026)

19.06.2026

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO SBIm PREMATURO

Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2026/2027

A vacinação de contactantes é especialmente indicada para quem convive ou cuida de RNPT* e inclui as vacinas: coqueluche, influenza, varicela, sarampo, caxumba, rubéola e COVID.

1º ano

Esse calendário é destinado a bebês prematuros sem comorbidades e apenas durante o primeiro ano de vida, devendo prosseguir a vacinação de acordo com o *Calendário de vacinação SBIm criança* a partir de 1 ano de idade.

Imunobiológicos recomendados no primeiro ano de vida	Esquemas e recomendações	Comentários	DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS	
			Gratuitas no PNI	Serviços privados de Vacinação
BCG ID	Dose única. Se PN** < 2.000 g, adiar a vacinação até que o RN*** atinja peso maior ou igual a 2.000 g.	Deverá ser aplicada o mais precocemente possível, de preferência ainda na maternidade. Em casos de histórico familiar, suspeita de imunodeficiência ou RNs cujas mães fizeram uso de biológicos durante a gestação, a vacinação poderá ser postergada ou contraindicada (consulte os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais).*	SIM	SIM
Hepatite B	Primeira dose nas primeiras 12 horas de vida. Continuidade: obrigatoriamente quatro doses (esquema 0-2-4-6 meses) em RNs nascidos com peso inferior a 2.000 g ou idade gestacional menor que 33 semanas	Os RNs de mães HBSAg+ devem receber ao nascer, além da vacina, imunoglobulina específica contra hepatite B (IGHAHB). Para a continuidade do esquema de doses, o uso da vacina Hexa acelular (DTPa-HB-VIP-Hib) deve ser preferido, inclusive para RNs hospitalizados.	SIM, UBS: hepatite B e DTPw-HB-Hib SIM, RIE: Hexa acelular	SIM, Hexa acelular
Rotavírus	• Vacinar na idade cronológica, iniciando aos 2 meses de vida. Vacina monovalente RV1: duas doses aos 2 e 4 meses de idade. Vacina pentavalente RV5: três doses aos 2, 4 e 6 meses de idade. Em caso de recuperação de esquemas de atraso vacinal, a D1 aplicar no máximo até 11 meses e 29 dias, e a última dose até 23 meses e 29 dias (uso off label). Intervalo mínimo entre doses de 30 dias. • Vacina de vírus vivo atenuado, oral, e portanto contraindicada em ambiente hospitalar.	• Se alguma dose na série for pentavalente (RV5) ou desconhecida, aplicar três doses. • Em caso de suspeita de imunodeficiência ou RNs cujas mães fizeram uso de biológicos durante a gestação, a vacina pode estar contraindicada ou ser adiada, desde que respeitando a idade máxima (consulte os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais).*	SIM, vacina monovalente	SIM, vacina pentavalente
Tríplice bacteriana (difteria, tétano, coqueluche)	• Vacinar na idade cronológica, iniciando aos 2 meses de vida, de acordo com o *Calendário de vacinação SBIm criança.* • Para RNs prematuros, hospitalizados ou não, utilizar preferencialmente vacinas acelulares, porque reduzem o risco de eventos adversos.	• Em prematuros extremos, considerar o uso de analgésicos/antitérmicos profiláticos com o intuito de reduzir a ocorrência de dor e febre. • As vacinas Penta acelular e Hexa acelular estão disponíveis na RIE para RN prematuro extremo (menor de 1.500 g ou de 33 semanas).	SIM, UBS: DTPw-Hib-HepB Sim, RIE: Penta e Hexa acelular	SIM, DTPa, Penta e Hexa acelular,
Haemophilus influenzae b	• Vacinar na idade cronológica, iniciando aos 2 meses de vida, de acordo com o *Calendário de vacinação SBIm criança.* • Reforço aos 15 meses de vida.	O uso das vacinas combinadas a DTPa (DTPa-HB-VIP-Hib ou DTPa-VIP-Hib) são preferenciais, pois permitem a aplicação simultânea e se mostraram eficazes e seguras para os RNPTs.	Sim, UBS: DTPw-Hib-HepB Sim, RIE: Hib, Penta e Hexa acelular	SIM, penta e hexa acelulares
Poliomielite inativada (VIP)	Vacinar na idade cronológica, iniciando aos 2 meses de vida, de acordo com o *Calendário de vacinação SBIm criança.*	Preferir as vacinas combinadas: DTPa-HB-VIP-Hib e DTPa-VIP-Hib	SIM, UBS: VIP SIM, RIE: VIP, Penta e Hexa acelular	SIM, Penta e Hexa acelular
Pneumocócicas conjugadas	Vacinar na idade cronológica, iniciando aos 2 meses de vida, de acordo com o *Calendário de vacinação SBIm criança.*	• RNPTs e de baixo PN apresentam maior risco para o desenvolvimento de doença pneumocócica invasiva, tanto maior quanto menor a idade gestacional e o baixo peso ao nascer. • A SBIm, com o intuito de ampliar a proteção para sorotipos recomenda no esquema básico e no reforço, preferencialmente, as vacinas VPC20 ou VPC15. Independente da VPC utilizada, sempre no esquema 3+1 para os que iniciam até os 6 meses de idade. • O PNI incluiu os prematuros (< ou = 36 semanas e seis dias) até 23 meses de idade na lista de recomendação da VPC20 na RIE. • Recomendações em comorbidades na RIE ver: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2026/nota-tecnica-no-52-2026-cgici-dpni-svsa-ms.pdf	SIM, UBS: VPC20/VPC10 (transição) SIM, RIE: VPC20	SIM, VPC20 e VPC15
Meningocócicas conjugadas ACWY ou C	Vacinar na idade cronológica, iniciando aos 3 meses de vida, de acordo com o *Calendário de vacinação SBIm criança.*	• Sempre que possível, preferir a vacina menACWY no esquema básico e nos reforços; na sua impossibilidade, utilizar a vacina meningocócica C conjugada.	SIM, UBS: menC aos 3 e 5 meses e menACWY no reforço aos 12 meses SIM, RIE: menACWY para algumas indicações	SIM, menC e menACWY
Meningocócicas B	Vacinar na idade cronológica, iniciando aos 3 meses de vida, de acordo com o *Calendário de vacinação SBIm criança.*	• A fim de reduzir a frequência de eventos adversos, a vacina meningocócica B deve ser aplicada preferencialmente em separado das vacinas pneumocócica e pertussis. • É aconselhável o uso de paracetamol profilático nas primeiras 24 horas após a vacinação, devido ao risco de febre alta que esta vacina pode desencadear como evento adverso.	NÃO	SIM
Influenza	Vacinar na idade cronológica, iniciando a partir dos 6 meses de vida, de acordo com a sazonalidade do vírus e com o *Calendário de vacinação SBIm criança.*	• Vacinas influenza 3V ou 4V – duas doses com intervalo de um mês entre elas. • A campanha de vacinação nos Estados da Região Norte tem início antecipado em relação às outras regiões do país (entre novembro e fevereiro), coincidindo com a sazonalidade regional. A vacina utilizada tem a formulação recomendada pela OMS para o Hemisfério Norte (HN).	SIM, 3V para menores de 6 anos e grupos de risco	SIM, 3V e 4V
Febre amarela	Vacinar na idade cronológica, aos 9 meses e aos 4 anos de idade (consulte o *Calendário de vacinação SBIm criança).*	Em caso de imunodeficiência, está contraindicada por ser vacina viva atenuada.	SIM	SIM
Covid-19	Rotina para crianças de 6 meses até menores de 5 anos de idade. Esquema de doses dependendo da	vacina utilizada. Ver *https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/covid-19*	SIM, para 6 meses a menores de 5 anos	NÃO

19/06/2026 • O uso simultâneo de múltiplas doses injetáveis em RNPTs hospitalizados pode associar-se a um maior risco de eventos adversos cardiovasculares, devendo-se dar preferência à administração de menor número de injeções em cada imunização • Qualquer dose não administrada na idade recomendada deve ser aplicada na visita subsequente • Eventos adversos significativos devem ser notificados às autoridades competentes.

* recém-nascido pré-termo
** peso ao nascimento
*** recém-nascido

* UBS – Unidades Básicas de Saúde
** RIE – Rede Imunobiológicos Especiais

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO SBIm PREMATURO

Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2026/2027

Esse calendário é destinado a bebês prematuros sem comorbidades e apenas durante o primeiro ano de vida, devendo prosseguir a vacinação de acordo com o *Calendário de vacinação SBIm criança* a partir de 1 ano de idade.

ANTICORPO MONOCLONAL

Imunobiológicos recomendados no primeiro ano de vida	Esquemas e recomendações	Comentários	DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS	
			Gratuitas no PNI	Serviços privados de vacinação
Anticorpo monoclonal contra o VSR (Nirsevimabe)	**Recomendações, independentemente da vacinação materna:** **PNI** Crianças prematuras (<37 de IG), menores de 6 meses de idade. Aplicar em qualquer época do ano, independente da sazonalidade. **SBIm** Crianças prematuras (<37 de IG), menores de 12 meses de idade. Aplicar em qualquer época do ano, independente da sazonalidade. *Esquemas:* • uma dose IM de 50 mg se peso < 5 Kg. • uma dose IM de 100mg se peso ≥5 Kg.	• Pode ser coadministrado com as demais vacinas recomendadas no *Calendário de vacinação SBIm Prematuro.* • A depender da situação epidemiológica e risco individual, a SBIm recomenda considerar outra dose de Nirsevimabe para prematuros menores de 12 meses, se a primeira dose foi aplicada há mais de seis meses, sobretudo para prematuros extremos e/ou com comorbidades. Decisão compartilhada entre família e pediatra.	SIM	SIM. Este medicamento está no rol da ANS, com cobertura pelos planos/ convênios de saúde para prematruros, obedecendo as mesmas recomendações do PNI.

IMUNOGLOBULINAS

Imunoglobulinas recomendadas no primeiro ano de vida	Esquemas e recomendações	Comentários	DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS	
			Gratuita nas UBS* e/ou nos RIE**	Serviços privados de vacinação
Imunoglobulina humana anti-hepatite B (IGHAHB)	Para RNs de mães portadoras do vírus da hepatite B: 0,5 mL via intramuscular.	Aplicar preferencialmente nas primeiras 12 a 24 horas de vida, até, no máximo, o sétimo dia de vida.	SIM	NÃO
Imunoglobulina humana antivaricela zóster (IGHAVZ)	Está recomendada nas seguintes situações: • Para prematuros nascidos entre 28 semanas e 36 semanas de gestação expostos à varicela, quando a mãe tiver história negativa para varicela. • Para prematuros nascidos com menos de 28 semanas de gestação ou com menos de 1.000 g de peso e expostos à varicela, independente da história materna de varicela. • A dose é de 125 UI por via IM e deve ser aplicada em até 96 horas após o contato.	Independente da idade gestacional ou PN, recomendar para RN cuja mãe tenha apresentado quadro clínico de varicela de cinco dias antes até dois dias depois do parto.	SIM	NÃO
Imunoglobulina humana antitetânica (IGHAT)	Está recomendada na dose de 250 UI, por via IM. Para RNs prematuros com lesões potencialmente tetanogênicas, independentemente da história vacinal da mãe.	Independente da idade gestacional ou PN, deve ser aplicada para RNs prematuros sob risco potencial de tétano.	SIM	NÃO

19/06/2026 • O uso simultâneo de múltiplas doses injetáveis em RNPTs hospitalizados pode associar-se a um maior risco de eventos adversos cardiovasculares, devendo-se dar preferência à administração de menor número de injeções em cada imunização • Qualquer dose não administrada na idade recomendada deve ser aplicada na visita subsequente • Eventos adversos significativos devem ser notificados às autoridades competentes.

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO SBIm ADOLESCENTE

Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2026/2027

10-19 anos

Os comentários devem ser consultados.

Para recomendações de vacinação para gestantes, consulte os *Calendário de vacinação SBIm gestante.*

Para definir vacinas e esquemas de doses na adolescência, considerar o passado vacinal.

Vacinas	Esquemas e recomendações	Comentários	DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS	
			Gratuitas no PNI	Serviços privados de vacinação
ROTINA				
HPV	• Duas vacinas estão disponíveis no Brasil, HPV4 e HPV9. A SBIm, com o intuito de ampliar a proteção para os tipos adicionais, recomenda, sempre que possível, o uso preferencial da vacina HPV9 em duas doses, assim como a revacinação daqueles anteriormente vacinados com HPV2 ou HPV4. Na impossibilidade do uso de HPV9, a HPV4 deve ser recomendada e está disponível gratuitamente nas UBS para meninas e meninos de 9 a 14 anos em dose única. • Esquema para não vacinados anteriormente: Adolescentes menores de 20 anos – duas doses com intervalo de seis meses entre elas (0-6 meses). • Para revacinação ou para dar sequência a esquemas iniciados com vacinas HPV2 ou HPV4, consulte posicionamento SBIm: https://sbim.org.br/images/files/notas-tecnicas/informe-sbim-esclarecimentos-vacinas-hpv-240415-v2.pdf	• Adolescentes mesmo que previamente expostos podem ser vacinados. • Contraindicada para gestantes. • PNI oferece a vacina HPV4 para os seguintes grupos: ◦ Crianças e adolescentes: 9-14 anos, dose única. ◦ Adolescentes: 15-19 anos, estratégia de resgate, dose única. ◦ Imunossuprimidos: 9-45 anos, três doses (0, 2 e 6 meses). ◦ Vítimas de violência sexual: 9-14 anos, duas doses (0 e 6 meses) e 15-45 anos, três doses (0, 2 e 6 meses). ◦ Usuários de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao HIV: 15-45 anos, três doses (0, 2 e 6 meses). ◦ Pessoas com papilomatose respiratória recorrente (PRR): a partir de 2 anos de idade, três doses (0, 2 e 6 meses). ◦ Mulheres que passaram por tratamento de lesões de alto grau no colo do útero: sem limite de idade, até 12 meses após o procedimento: três doses (0, 2 e 6 meses).	SIM, HPV4 – uma dose para meninas e meninos de 9 a 14 anos	SIM, HPV9
Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (difteria, tétano e coqueluche) – dTpa ou dTpa-VIP Dupla adulto (difteria e tétano) – dT	**Com esquema de vacinação completo, incluindo a dose dos 9-11 anos**: dose de reforço, preferencialmente com dTpa, dez anos após a última. **Com esquema de vacinação incompleto**: uma dose de dTpa a qualquer momento e completar a vacinação básica com dT (dupla bacteriana do tipo adulto) de forma a totalizar três doses de vacina contendo o componente tetânico. **Não vacinados e/ou histórico vacinal desconhecido**: uma dose de dTpa e duas doses de dT no esquema 0-2-4 a 8 meses.	• Atualizar dTpa com intervalo mínimo de quatro semanas de dose anterior de dT ou TT. • O uso da vacina dTpa, em substituição à dT, para adolescentes, objetiva, além da proteção individual, a redução da transmissão da *Bordetella pertussis*, principalmente para suscetíveis com alto risco de complicações, como os lactentes. • Considerar antecipar reforço com dTpa para cinco anos após a última dose de vacina contendo o componente *pertussis* para adolescentes contactantes de lactentes. • Para adolescentes que pretendem viajar para países nos quais a poliomielite é endêmica recomenda-se a vacina dTpa combinada à pólio inativada (dTpa-VIP). • A dTpa-VIP pode substituir a dTpa, inclusive em gestantes, ficando a critério médico o uso *off label* nesses casos. • A vacina está recomendada mesmo para aqueles que tiveram coqueluche, já que a proteção conferida pela infecção não é permanente.	SIM, dT para todos. dTpa para gestantes e puérperas até 45 dias após o parto	SIM, dTpa e dTpa-VIP
Influenza (gripe)	• Dose única anual. • Em adolescentes com fatores de risco e em situação epidemiológica que justifique, pode ser considerada uma segunda dose, a partir de 3 meses após a dose anual.	A campanha de vacinação nos Estados da Região Norte tem início antecipado em relação às outras regiões do país (entre novembro e fevereiro), coincidindo com a sazonalidade regional. A vacina utilizada tem a formulação recomendada pela OMS para o Hemisfério Norte (HN). A vacina do Hemisfério Sul poderá ser recomendada como dose extra para crianças em situações de risco ou para brasileiros viajantes internacionais ou com destino aos estados do Norte do país. A efetividade vai depender do match (combinação) com as cepas circulantes quando da dose extra.	SIM, 3V para grupos de risco	SIM, 3V e 4V
Meningocócica conjugada ACWY ou C	• Para vacinados na infância: reforço aos 11 anos ou cinco anos após a última dose. • Para não vacinados até 15 anos, duas doses com intervalo de cinco anos, a partir de 16 anos, uma dose.	Na indisponibilidade da vacina meningocócica conjugada ACWY, substituir pela vacina meningocócica C conjugada.	SIM, menACWY (11 a 14 anos)	SIM
Meningocócica B	Duas doses com intervalo mínimo de um mês (Bexsero®).	Para grupos de alto risco para doença meningocócica invasiva (DMI), os esquemas primários assim como a necessidade de reforços são diferentes. Consulte os *Calendários SBIm Pacientes Especiais.*	NÃO	SIM
Covid-19	Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados	pelo PNI em https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/covid-19		
RECOMENDADAS PARA NÃO VACINADOS OU INCOMPLETAMENTE VACINADOS				
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)	• Duas doses acima de 1 ano de idade, com intervalo mínimo de um mês entre elas. • Para adolescentes com esquema completo, não há evidências que justifiquem uma terceira dose como rotina, podendo ser considerada em situações de risco epidemiológico, como surtos de caxumba e/ou sarampo.	• Contraindicada para gestantes. O uso em imunodeprimidos deve ser avaliado pelo médico (consulte os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais*). • Para suscetíveis, considerar a aplicação de vacina combinada tetraviral (SCRV).	SIM, SCR	SIM, SCR e SCRV
Varicela (catapora)	**Para suscetíveis:** duas doses. **Para menores de 13 anos:** intervalo de três meses. **A partir de 13 anos:** intervalo de um a dois meses.	• O uso em imunodeprimidos deve ser avaliado pelo médico (consulte os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais*). • Para suscetíveis, considerar a aplicação de vacina combinada tetraviral (SCRV).	NÃO	SIM, varicela e SCRV
Hepatites A, B ou A e B	**Hepatite A:** duas doses, no esquema 0-6 meses.	• Adolescentes não vacinados na infância para as hepatites A e B devem ser vacinados o mais precocemente possível. • A vacina combinada para as hepatites A e B é uma opção e pode substituir a vacinação isolada para as hepatites A e B.	NÃO	SIM
	Hepatite B: três doses, esquema 0-1-6 meses.		SIM	NÃO
	Hepatite A e B: para menores de 16 anos: duas doses aos 0-6 meses. A partir de 16 anos: três doses aos 0-1-6 meses.		NÃO	SIM
Febre amarela	• **Recomendação do PNI:** se recebeu a primeira dose antes dos 5 anos, indicada uma segunda dose, independentemente da idade atual. Se aplicada a partir dos 5 anos de idade: dose única. • **Recomendação da SBIm:** Duas doses. Como há possibilidade de falha vacinal, está recomendada uma segunda dose com intervalo de 10 anos. • Essa vacina pode ser exigida para emissão do CIVP, atendendo exigências sanitárias de alguns destinos internacionais. Neste caso, deve ser aplicada até dez dias antes de viajar.	• É contraindicada em nutrizes até que o bebê complete 6 meses; se a vacinação não puder ser evitada, suspender o aleitamento materno por dez dias. • O uso em imunodeprimidos deve ser avaliado pelo médico (consulte os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais*). • Para gestantes: consulte o *Calendário de vacinação SBIm gestante*.	SIM	SIM
Dengue*	• Qdenga® é preferencial por poder ser utilizada independente de contato prévio com o vírus da dengue. Esquema de duas doses com intervalo de três meses entre elas (0-3 meses).	• Qdenga® licenciada para pessoas entre 4 e 60 anos. • Contraindicada para gestantes e nutrizes.	SIM, Qdenga® para 10 a 14 anos	SIM

17/06/2026 • Sempre que possível, preferir vacinas combinadas e/ou considerar aplicações simultâneas na mesma visita. • Qualquer dose não administrada na idade recomendada deve ser aplicada na visita subsequente • ESAVI significativos devem ser notificados às autoridades competentes.

*Ver notas técnicas do MS: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dengue/notas-tecnicas

Algumas vacinas podem estar especialmente recomendadas para pacientes portadores de comorbidades ou em outra situação especial. Consulte os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais.*

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO SBIm ADULTO

Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2026/2027

20-59 anos

Os comentários devem ser consultados.

Para recomendações de vacinação para gestantes, consulte os *Calendário de vacinação SBIm gestante.*

Vacinas	Esquemas e recomendações	Comentários	DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS	
			Gratuitas no PNI	Serviços privados de vacinação
Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (difteria, tétano e coqueluche) – dTpa ou dTpa-VIP **Dupla adulto (difteria e tétano) – dT**	• Atualizar dTpa com intervalo mínimo de quatro semanas de dose anterior de dT ou TT. • **Com esquema de vacinação básico completo:** reforço com dTpa a cada dez anos. • **Com esquema de vacinação básico incompleto:** uma dose de dTpa a qualquer momento e completar a vacinação básica com dT (dupla bacteriana do tipo adulto) de forma a totalizar três doses de vacina contendo o componente tetânico. • **Não vacinados e/ou histórico vacinal desconhecido:** uma dose de dTpa e duas doses de dT no esquema 0-2-4 a 8 meses. • **Para indivíduos que pretendem viajar para países nos quais a poliomielite é endêmica: recomenda-se a vacina dTpa combinada à pólio inativada (dTpa-VIP). A dTpa-VIP pode substituir a dTpa.**	• A dTpa está recomendada mesmo para aqueles que tiveram a coqueluche, já que a proteção conferida pela infecção não é permanente. • O uso da vacina dTpa, em substituição à dT, objetiva, além da proteção individual, a redução da transmissão da *Bordetella pertussis*, principalmente para suscetíveis com alto risco de complicações, como os lactentes. • Considerar antecipar reforço com dTpa para cinco anos após a última dose de vacina contendo o componente *pertussis* em adultos contactantes de lactentes.	SIM, dT e dTpa para gestantes, puérperas e profissionais da saúde	SIM, dTpa e dTpa-VIP
Influenza (gripe)	• Dose única anual. • Em adultos com fatores de risco e em situação epidemiológica que justifique, pode ser considerada uma segunda dose, a partir de 3 meses após a dose anual.	• A campanha de vacinação nos Estados da Região Norte tem início antecipado em relação às outras regiões do país (entre novembro e fevereiro), coincidindo com a sazonalidade regional. A vacina utilizada tem a formulação recomendada pela OMS para o Hemisfério Norte (HN). • A vacina do Hemisfério Sul poderá ser recomendada como dose extra em situações de risco ou para brasileiros viajantes internacionais ou com destino aos estados do Norte do país. A efetividade vai depender do match (combinação) com as cepas circulantes quando da dose extra.	SIM, 3V para adultos pertencentes a grupos de risco	SIM, 3V E 4V
Pneumocócica conjugada VPC20	• Rotina a partir dos 50 anos de idade. • Esquema: VPC20 em dose única.	• A vacina VPC20 é indicada para adultos de qualquer idade com comorbidades de risco para DPI (consulte os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais*). • Recomendações em comorbidades na RIE ver: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2026/nota-tecnica-no-52-2026-cgici-dpni-svsa-ms.pdf	NÃO, nas UBS. SIM, VPC20 para acamados, hospitalizados e/ou institucionalizados e na RIE para comorbidades.	SIM, VPC20
Herpes zóster	• Rotina a partir de 50 anos. • Esquema: Vacina inativada (VZR) – duas doses com intervalo de dois meses (0-2).	• A vacinação está recomendada mesmo para aqueles que já desenvolveram a doença. Intervalo entre quadro de HZ e vacinação: seis meses ou após resolução do quadro, considerando a perda de oportunidade vacinal. • A VZR está recomendada para vacinados previamente com a vacina atenuada (VZA), respeitando intervalo mínimo de dois meses entre elas. • Uso em imunodeprimidos: VZR recomendada (consulte os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais*)	NÃO	SIM, VZR
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)	• Duas doses acima de 1 ano de idade, com intervalo mínimo de um mês entre elas. • Para adultos com esquema completo, não há evidências que justifiquem uma terceira dose como rotina, podendo ser considerada em situações de risco epidemiológico, como surtos de caxumba e/ou sarampo.	• Para suscetíveis, considerar a aplicação de vacina combinada tetraviral (SCRV). • O uso em imunodeprimidos deve ser avaliado pelo médico (consulte os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais*).	SIM, duas doses até 29 anos; uma dose entre 30 e 59 anos	SIM
Varicela (catapora)	**Para suscetíveis:** duas doses com intervalo de um a dois meses.	• Para suscetíveis, considerar a aplicação de vacina combinada tetraviral (SCRV). • O uso em imunodeprimidos deve ser avaliado pelo médico (consulte os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais*).	NÃO	SIM
Hepatites A, B ou A e B	**Hepatite A:** duas doses, no esquema 0-6 meses.	• Adultos não vacinados anteriormente e suscetíveis, devem ser vacinados para as hepatites A e B. • A vacina combinada para as hepatites A e B é uma opção e pode substituir a vacinação isolada para as hepatites A e B.	NÃO	SIM
	Hepatite B: três doses, no esquema 0-1-6 meses.		SIM	NÃO
	Hepatite A e B: três doses, no esquema 0-1-6 meses.		NÃO	SIM
HPV	• Duas vacinas estão disponíveis no Brasil, HPV4 e HPV9. A SBIm, com o intuito de ampliar a proteção para os tipos adicionais, recomenda, sempre que possível, o uso preferencial da vacina HPV9 em três doses, assim como a revacinação daqueles anteriormente vacinados com HPV2 ou HPV4. • Adultos com 20 anos ou mais, não vacinados anteriormente: três doses da HPV9 (0-1 a 2-6 meses). • Para revacinação ou para dar sequência a esquemas iniciados com vacinas HPV2 ou HPV4 consulte posicionamento SBIm: https://sbim.org.br/images/files/notas-tecnicas/informe-sbim-esclarecimentos-vacinas-hpv-240415-v2.pdf	• Adultos, mesmo que previamente expostos, podem ser vacinados. • A vacinação em maiores de 45 anos (fora da faixa de licenciamento) pode ser recomendada pelo médico em decisão compartilhada com seu paciente. • Contraindicada para gestantes. • PNI oferece a vacina HPV4 para os seguintes grupos: ◦ Imunossuprimidos: 9-45 anos, três doses (0, 2 e 6 meses). ◦ Vítimas de violência sexual: 15-45 anos, três doses (0, 2 e 6 meses). ◦ Usuários de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao HIV: 15-45 anos, três doses (0, 2 e 6 meses). ◦ Pessoas com papilomatose respiratória recorrente (PRR): a partir de 2 anos de idade, três doses (0, 2 e 6 meses). ◦ Mulheres que passaram por tratamento de lesões de alto grau no colo do útero: sem limite de idade, até 12 meses após o procedimento, três doses (0, 2 e 6 meses).	NÃO	SIM, HPV9
Meningocócicas conjugadas ACWY ou C	Uma dose. A indicação da vacina, assim como a necessidade de reforços, dependerão da situação epidemiológica.	Na indisponibilidade da vacina meningocócica conjugada ACWY, substituir pela vacina meningocócica C conjugada.	NÃO	SIM
Meningocócica B	• A indicação dependerá da situação epidemiológica. • Duas doses com intervalo mínimo de 1 mês (Bexsero®). • Não se conhece a duração da proteção conferida e, consequentemente, a necessidade de dose(s) de reforço.	• Para grupos de alto risco para doença meningocócica invasiva (DMI), os esquemas primários assim como a necessidade de reforços são diferentes (consulte os *Calendários SBIm Pacientes Especiais*). • Bexsero® licenciada até os 50 anos de idade. O uso acima dessa idade é *off label*.	NÃO	SIM
Febre amarela	• **Recomendação do PNI:** se recebeu a primeira dose antes dos 5 anos, indicada uma segunda dose, independentemente da idade atual. Se aplicada a partir dos 5 anos de idade: dose única. • **Recomendação da SBIm:** Duas doses. Como há possibilidade de falha vacinal, está recomendada uma segunda dose com intervalo de 10 anos. • Essa vacina pode ser exigida para emissão do CIVP, atendendo exigências sanitárias de alguns destinos internacionais. Neste caso, deve ser aplicada até dez dias antes de viajar.	• É contraindicada em nutrizes até que o bebê complete 6 meses; se a vacinação não puder ser evitada, suspender o aleitamento materno por dez dias. • O uso em imunodeprimidos e gestantes deve ser avaliado pelo médico (consulte os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais* e/ou *Calendário de vacinação SBIm gestante).*	SIM	SIM
Dengue	• Qdenga® pode ser utilizada em adultos até 60 anos independente de contato prévio com o vírus da dengue. Esquema de duas doses com intervalo de três meses entre elas (0-3 meses).	Contraindicada para gestantes e lactantes.	NÃO	SIM
Vírus Sincicial Respiratório	• Não recomendada como rotina.	• Duas vacinas disponíveis: Arexvy® (GSK) e Abrysvo® (Pfizer), no esquema de uma dose, IM. • A partir dos 18 anos de idade recomendadas para pessoas com doenças cardiovasculares ou respiratórias crônicas clinicamente relevantes, pelo risco de evolução grave ou descompensação, priorizando insuficiência cardíaca, doença coronariana, DPOC, asma moderada/grave e imunodeficiências moderadas/graves, especialmente se fragilizadas, acamadas e/ou residentes em instituições de longa permanência. Em diabetes, doença hepática crônica, obesidade, condições neurológicas, entre outras comorbidades de risco, a vacinação poderá ser considerada à critério médico. Ver recomendações no *Calendário de vacinação SBIm pacientes especiais* • Não há dados disponíveis que comprovem a necessidade de doses adicionais. • Somente a vacina Abrysvo® (Pfizer) está licenciada para gestantes. Deve ser aplicada em gestantes de qualquer idade, a partir de 28 semanas de gestação, a cada gestação. Uso entre 24 e 27 semanas de IG a critério médico.	SIM, somente para gestantes	SIM
Covid-19	Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/covid-19			

17/06/2026 • Sempre que possível, preferir vacinas combinadas e/ou considerar aplicações simultâneas na mesma visita. • Qualquer dose não administrada na idade recomendada deve ser aplicada na visita subsequente • Eventos adversos significativos devem ser notificados às autoridades competentes.

Algumas vacinas podem estar especialmente recomendadas para pacientes portadores de comorbidades ou em outra situação especial. Consulte os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais.*

ADULTO

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO SBIm GESTANTE

Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2026/2027

Os comentários devem ser consultados.

Algumas vacinas podem estar especialmente recomendadas para pacientes portadores de comorbidades ou em outra situação especial. Consulte os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais.*

Vacinas	Esquemas e recomendações		Comentários	DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS	
				Gratuitas no PNI	Serviços privados de vacinação
ROTINA					
Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (difteria, tétano e coqueluche) – dTpa ou dTpa-VIP Dupla adulto (difteria e tétano) – dT	**Histórico vacinal**	**Conduta na gestação**	• A dTpa está recomendada em todas as gestações, pois além de proteger a gestante e evitar que ela transmita a *Bordetella pertussis* ao recém-nascido, permite a transferência de anticorpos ao feto protegendo-o nos primeiros meses de vida até que possa ser imunizado. • Mulheres não vacinadas na gestação devem ser vacinadas no puerpério, o mais precocemente possível. • Na indisponibilidade de dTpa, pode-se substituí-la pela dTpa-VIP, ficando a critério médico a prescrição.	SIM, dT e dTpa	SIM, dTpa e dTpa-VIP
	Previamente vacinada, com pelo menos três doses de vacina contendo o componente tetânico.	Uma dose de dTpa a partir da 20ª semana de gestação.			
	Em gestantes com vacinação incompleta tendo recebido uma dose de vacina contendo o componente tetânico.	Uma dose de dT e uma dose de dTpa, sendo que a dTpa deve ser aplicada a partir da 20ª semana de gestação. Respeitar intervalo mínimo de um mês entre elas.			
	Em gestantes com vacinação incompleta tendo recebido duas doses de vacina contendo o componente tetânico.	Uma dose de dTpa a partir da 20ª semana de gestação.			
	Em gestantes não vacinadas e/ou histórico vacinal desconhecido.	Duas doses de dT e uma dose de dTpa, sendo que a dTpa deve ser aplicada a partir da 20ª semana de gestação. Respeitar intervalo mínimo de um mês entre elas.			
Hepatite B	Três doses, no esquema 0-1-6 meses.		A vacina hepatite B deve ser aplicada em gestantes não anteriormente vacinadas.	SIM	NÃO
Influenza (gripe)	Dose única anual. Em situação epidemiológica de risco, especialmente para gestantes com fatores de risco, pode ser considerada uma segunda dose a partir de 3 meses após a dose anual.		• A gestante é grupo de risco para complicações da infecção pelo influenza. A vacina está recomendada durante a sazonalidade do vírus, mesmo no primeiro trimestre da gestação. • A campanha de vacinação nos Estados da Região Norte tem início antecipado em relação às outras regiões do país (entre novembro e fevereiro), coincidindo com a sazonalidade regional. A vacina utilizada tem a formulação recomendada pela OMS para o Hemisfério Norte (HN). • A vacina do Hemisfério Sul poderá ser recomendada como dose extra para gestantes em situações de risco ou para brasileiras viajantes internacionais ou com destino aos estados do Norte do país. A efetividade vai depender do *match* (combinação) com as cepas circulantes quando da dose extra.	SIM, 3V	SIM, 3V e 4V
Vírus Sincicial Respiratório	• Vacina VSR (Abrysvo®) • Recomendada para gestantes de qualquer idade. • Uma dose, IM, aplicada a partir de 28 semanas de gestação, sem limite superior de idade gestacional. • Aplicada a qualquer momento, independente de sazonalidade. • Repetir em cada gestação.		• A vacina VSR (Abrysvo®) é licenciada pela ANVISA de 24 a 36 semanas de gestação, ficando a critério médico a recomendação em idades gestacionais entre 24 e 27 semanas. • Pode ser coadministrada com as outras vacinas de rotina da gestante. • Existem duas estratégias para proteção da criança contra infecção pelo VSR: a vacinação da gestante e a administração do anticorpo monoclonal – Nirsevimabe – na criança. Ver calendários de vacinação SBIm do prematuro e da criança.	SIM	SIM
Covid-19	Dose única, independente do histórico vacinal. O esquema altera na presença de imunossupressão.		• Vacinar a cada gestação, a qualquer momento. • Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/covid-19	SIM	NÃO
RECOMENDADAS EM SITUAÇÕES ESPECIAIS					
Hepatite A	Duas doses, no esquema 0-6 meses.		É vacina inativada, portanto sem risco teórico para a gestante e o feto. Já que no Brasil as situações de risco de exposição ao VHA são frequentes, a vacinação deve ser considerada.	NÃO	SIM
Hepatite A e B	Para menores de 16 anos: duas doses, aos 0-6 meses. A partir de 16 anos: três doses, aos 0-1-6 meses.		A vacina combinada é uma opção e pode substituir a vacinação isolada das hepatites A e B.	NÃO	SIM
Pneumocócicas	Em gestantes de risco para doença pneumocócica invasiva (DPI) pode ser aplicada VPC20 em dose única (consulte os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais*).		VPC20 é vacina inativada, portanto sem riscos teóricos para a gestante e o feto.	NÃO	SIM, VPC20
Meningocócicas conjugadas ACWY ou C	Uma dose. Considerar seu uso avaliando a situação epidemiológica e/ou a presença de comorbidades consideradas de risco para a doença meningocócica (*consulte os Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais).*		• As vacinas meningocócicas conjugadas são inativadas, portanto sem risco teórico para a gestante e o feto. • Na indisponibilidade da vacina meningocócica conjugada ACWY, substituir pela vacina meningocócica C conjugada.	NÃO	SIM
Meningocócica B	• Considerar seu uso avaliando a situação epidemiológica e/ou a presença de comorbidades consideradas de alto risco para a doença meningocócica invasiva (DMI). Consulte os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais.* • Duas doses com intervalo mínimo de 1 mês (Bexsero®).		• A vacina meningocócica B é inativada, portanto sem risco teórico para a gestante e o feto. • Bexsero® licenciada até os 50 anos de idade.	NÃO	SIM
Febre amarela	• Normalmente contraindicada em gestantes. Porém, em situações em que o risco da infecção supera os riscos potenciais da vacinação, pode ser feita durante a gravidez. • Recomendação do PNI: se recebeu a primeira dose antes dos 5 anos de idade, indicada uma segunda dose. Se aplicada a partir dos 5 anos: dose única. • Recomendação da SBIm: Duas doses. Como há possibilidade de falha vacinal, está recomendada uma segunda dose com intervalo de 10 anos.		• Gestantes que viajam para países que exigem o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP) devem ser isentadas da vacinação pelo médico assistente, se não houver risco de contrair a infecção. • É contraindicada em nutrizes até que o bebê complete 6 meses; se a vacinação não puder ser evitada, suspender o aleitamento materno por dez dias.	SIM	SIM
CONTRAINDICADAS					
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)	Não vacinar na gestação.		Pode ser aplicada no puerpério e durante a amamentação.	SIM, para puérperas de até 59 anos	SIM, para puérperas e lactantes
HPV	Não vacinar na gestação. Se a mulher tiver iniciado esquema antes da gestação, suspendê-lo e retomar esquema de doses no puerpério.		• Pode ser aplicada no puerpério e durante a amamentação. • O PNI oferece a a vacina HPV4, além da rotina, para determinadas situações de risco: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/h/hpv/publicacoes/esquema-vacinal-hpv	NÃO	SIM, para puérperas e lactantes
Varicela (catapora)	Não vacinar na gestação.		Pode ser aplicada no puerpério e durante a amamentação.	NÃO	SIM, para puérperas e lactantes
Dengue	Não vacinar na gestação.		Contraindicada para gestantes e nutrizes. Na vacinação inadvertida de lactantes que amamentam bebês de até 6 meses de idade, suspender a amamentação por 15 dias.	NÃO	NÃO

17/06/2025 • Sempre que possível, preferir vacinas combinadas e/ou considerar aplicações simultâneas na mesma visita • Qualquer dose não administrada na idade recomendada deve ser aplicada na visita subsequente • Eventos adversos significativos devem ser notificados às autoridades competentes.

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO SBIm IDOSO

Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2026/2027

60+ anos

Os comentários devem ser consultados.

Algumas vacinas podem estar especialmente recomendadas para pessoas com comorbidades ou em outra situação especial. Consulte os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais*.

Vacinas	Quando indicar	Esquemas e recomendações	Comentários	DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS	
				Gratuitas no PNI	Serviços privados de vacinação
ROTINA					
Influenza (gripe)	Rotina.	Dose única anual, preferencialmente com a vacina trivalente de alta concentração (*high dose*, HD3V). Na impossibilidade, usar a vacina disponível (3V ou 4V) e, nesses casos, em situação epidemiológica de risco, considerar uma segunda dose a partir de três meses após a dose anual.	• A campanha de vacinação nos Estados da Região Norte tem início antecipado em relação às outras regiões do país (entre novembro e fevereiro), coincidindo com a sazonalidade regional. A vacina utilizada tem a formulação recomendada pela OMS para o Hemisfério Norte (HN). • A vacina do Hemisfério Sul poderá ser recomendada como dose extra em situações de risco ou para brasileiros viajantes internacionais ou com destino aos estados do Norte do país. A efetividade vai depender do match (combinação) com as cepas circulantes quando da dose extra.	SIM, 3V	SIM, 3V, 4V e HD3V
Pneumocócica conjugada VPC20	Rotina.	• VPC20 em dose única.	• Idosos não vacinados previamente: VPC20 em dose única. • Para aqueles que já receberam VPP23 (uma ou duas doses), recomenda-se o intervalo de um ano para a aplicação de VPC20. • Para aqueles com esquema sequencial incompleto com VPC13 ou VPC15 e/ou VPP23, finalizar a vacinação com dose única de VPC20, respeitando intervalo de dois meses da última dose da VPC13 ou VPC15 ou um ano da vacina VPP23. • Para aqueles com esquema sequencial completo com VPC13 e/ou VPC15 e VPP23, uma dose de VPC20 pode ser recomendada a critério médico, respeitando intervalo de um ano da dose de VPP23 e de 2 meses da VPC13, VPC15. • Recomendações em comorbidades na RIE ver: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2026/nota-tecnica-no-52-2026-cgici-dpni-svsa-ms.pdf	SIM, VPC20. Na RIE para grupos de risco e como rotina para idosos que vivem acamados, hospitalizados e/ou institucionalizados.	SIM, VPC20
Herpes zóster	Se não vacinado aos 50, a qualquer momento.	• Rotina a partir de 50 anos. • Esquema: Vacina inativada (VZR) – duas doses com intervalo de dois meses (0-2).	• A vacinação está recomendada mesmo para aqueles que já desenvolveram a doença. Intervalo entre quadro de HZ e vacinação: seis meses ou após resolução do quadro, considerando a perda de oportunidade vacinal. • A VZR está recomendada para vacinados previamente com a vacina atenuada (VZA), respeitando intervalo mínimo de dois meses entre elas. • Uso em imunodeprimidos: VZR recomendada (consulte os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais*).	NÃO	SIM, VZR
Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (difteria, tétano e coqueluche) – dTpa ou dTpa-VIP Dupla adulto (difteria e tétano) – dT	Rotina.	• Atualizar dTpa com intervalo mínimo de quatro semanas de dose anterior de dT ou TT. • **Com esquema de vacinação básico completo:** reforço com dTpa a cada dez anos. • **Com esquema de vacinação básico incompleto:** uma dose de dTpa a qualquer momento e completar a vacinação básica com uma ou duas doses de dT (dupla bacteriana do tipo adulto) de forma a totalizar três doses de vacina contendo o componente tetânico. • **Não vacinados e/ou histórico vacinal desconhecido:** uma dose de dTpa e duas doses de dT no esquema 0-2-4 a 8 meses.	• A vacina está recomendada mesmo para aqueles que tiveram a coqueluche, já que a proteção conferida pela infecção não é permanente. • Considerar antecipar reforço com dTpa para cinco anos após a última dose de vacina contendo o componente *pertussis* para idosos contactantes de lactentes. • Para idosos que pretendem viajar para países nos quais a poliomielite é endêmica recomenda-se a vacina dTpa combinada à pólio inativada (dTpa-VIP). • A dTpa-VIP pode substituir a dTpa, se necessário.	SIM, dT e dTpa para profissionais da saúde	SIM, dTpa e dTpa-VIP
Hepatite B	Para idosos não vacinados previamente.	Três doses, no esquema 0-1-6 meses.	–	SIM	NÃO
Febre amarela	Para idosos não vacinados previamente.	• **Recomendação PNI:** Se aplicada a partir dos 5 anos de idade: dose única. A partir dos 60 anos, o serviço de saúde deverá avaliar a indicação, considerando o risco da doença e o risco de eventos adversos nessa faixa etária e/ou decorrentes de comorbidades. • **Recomendação SBIm:** Duas doses. Como há possibilidade de falha vacinal, está recomendada uma segunda dose com intervalo de 10 anos.	• O uso em imunodeprimidos deve ser avaliado pelo médico (consulte os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais*) • Essa vacina pode ser exigida para emissão do CIVP, atendendo exigências sanitárias de alguns destinos internacionais. Neste caso, deve ser aplicada até dez dias antes de viajar.	SIM	SIM
Vírus Sincicial Respiratório	A partir dos 60 anos recomendada para pessoas com maior risco de evolução grave ou descompensação da doença de base pela infecção pelo VSR (ver Comentários). Indicada como rotina a partir dos 70 anos, independente de fatores de risco.	• Duas vacinas disponíveis: Arexvy® (GSK) e Abrysvo® (Pfizer). • Uma dose. Aplicar a qualquer momento, independente da sazonalidade.	• A partir dos 60 anos recomendada para pessoas com maior risco de evolução grave ou descompensação da doença de base pela infecção pelo VSR, como: cardiopatia, pneumopatia, diabetes, obesidade, nefropatia, hepatopatia e imunossupressão Também deve ser recomendada para pessoas fragilizadas, acamadas e/ou residentes em instituições de longa permanência. • Por serem vacinas inativadas o uso concomitante com outras vacinas recomendadas para a idade é permitido. Porém, estudos de segurança e imunogenicidade de aplicação simultânea estão em andamento. • Não há dados disponíveis que comprovem a necessidade de doses adicionais.	NÃO	SIM
Covid-19	Rotina	Uma dose de seis em seis meses.	Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/covid-19	SIM	NÃO
EM SITUAÇÕES ESPECIAIS					
Hepatite A	Após avaliação sorológica ou em situações de exposição ou surtos.	Duas doses, no esquema 0-6 meses.	Na população com mais de 60 anos é incomum encontrar indivíduos suscetíveis. Para esse grupo, portanto, a vacinação não é prioritária. A sorologia pode ser solicitada para definição da necessidade ou não de vacinar. Em contactantes de doentes com hepatite A, ou durante surto da doença, a vacinação deve ser recomendada.	NÃO	SIM
Hepatites A e B	Quando recomendadas as duas vacinas.	Três doses, no esquema 0-1-6 meses.	A vacina combinada para as hepatites A e B é uma opção e pode substituir a vacinação isolada para as hepatites A e B.	NÃO	SIM
Meningocócicas conjugadas ACWY ou C	Surtos e viagens para áreas de risco.	Uma dose. A indicação da vacina, assim como a necessidade de reforços, dependerão da situação epidemiológica.	Na indisponibilidade da vacina meningocócica conjugada ACWY, substituir pela vacina meningocócica C conjugada.	NÃO	SIM
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)	Situações de risco aumentado.	Uma dose. A indicação da vacina dependerá de risco epidemiológico e da situação individual de suscetibilidade.	Na população com mais de 60 anos é incomum encontrar indivíduos suscetíveis ao sarampo, caxumba e rubéola. Para esse grupo, portanto, a vacinação não é rotineira. Porém, a critério médico (em situações de surtos, viagens, entre outros), pode ser recomendada. Contraindicada para imunodeprimidos.	NÃO	SIM

17/06/2026 • Sempre que possível, preferir vacinas combinadas e/ou considerar aplicações simultâneas na mesma visita. • Qualquer dose não administrada na idade recomendada deve ser aplicada na visita subsequente • Eventos adversos significativos devem ser notificados às autoridades competentes.

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO SBIm CRIANÇA

Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2026/2027

0<10 anos

Os comentários numerados devem ser consultados.

VACINAS	DO NASCIMENTO AOS 2 ANOS DE IDADE													DOS 2 A <10 ANOS					DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS	
	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	Gratuitas no PNI	Serviços privados de vacinação
BCG ID [1]	Dose única																		SIM	NÃO
Hepatite B [2]	Três ou quatro doses, dependendo da vacina utilizada																		SIM, isolada e combinadas*	SIM, isolada e combinadas*
Rotavírus [3]			Duas ou três doses, dependendo da vacina utilizada																Vacina monovalente	SIM, vacina pentavalente
Tríplice bacteriana (DTPw ou DTPa) [4]			1ª dose		2ª dose		3ª dose					REFORÇO			REFORÇO				Penta de células inteiras e Tríplice de células inteiras	Penta e hexa acelulares e DTPa-VIP
Haemophilus influenzae b [5]			1ª dose		2ª dose		3ª dose					REFORÇO							Penta de células inteiras	SIM, penta e hexa acelulares
Poliomielite (vírus inativados) [6]			1ª dose		2ª dose		3ª dose					REFORÇO			REFORÇO				VIP três doses aos 2, 4 e 6 meses e um reforço aos 15 meses	Penta e hexa acelulares, DTPa-VIP e dTpa-VIP
Pneumocócicas conjugadas [7]			Duas ou três doses, dependendo da vacina utilizada								REFORÇO								SIM, UBS: VPC20/ VPC10 (transição) SIM, RIE: VPC20	SIM, VPC20 E VPC15
Meningocócicas conjugadas ACWY ou C [8]				1ª dose		2ª dose					REFORÇO					REFORÇO			menC aos 3 e 5 meses, menACWY no reforço aos 12 meses e para 11-14 anos	menC e menACWY
Meningocócica B [9]				1ª dose		2ª dose					REFORÇO								NÃO	SIM
Influenza (gripe) [10]							NA PRIMOVACINAÇÃO DE MENORES DE 9 ANOS: DUAS DOSES COM INTERVALO DE UM MÊS. APÓS, DOSE ÚNICA ANUAL.												3V para menores de 6 anos e grupos de risco	3V e 4V
Febre amarela [11]										1ª dose					2ª dose				SIM	SIM
Hepatite A [12]											1ª dose		2ª dose						SIM, dose única aos 15 meses (até menores de 5 anos)	SIM, isolada e combinada*
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) [13,15]											1ª dose	2ª dose							SIM	SIM
Varicela (catapora) [14,15]											1ª dose	2ª dose							Duas doses (aos 15 meses e entre 4 e 6 anos)	SIM
HPV [16]																		Duas doses	SIM, HPV4 – uma dose para meninas e meninos de 9 a 14 anos.	HPV9
Vacina tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (dTpa) [4]																		REFORÇO	NÃO	SIM, dTpa e dTpa-VIP
Dengue [17]															Qdenga®, em duas doses, independente de contato prévio com o vírus da dengue.				SIM, Qdenga® para 10 a 14 anos	SIM
Covid-19 [18]							Rotina para crianças de 6 meses até menores de 5 anos de idade. Esquema de doses dependendo da vacina utilizada. Ver https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/covid-19												SIM, para 6 meses a menores de 5 anos	NÃO
Anticorpo monoclonal específico contra o VSR																				
Nirsevimabe [19]	Recomendado para crianças <12 meses de idade, em dose única. Dos 12 aos < 24 meses de idade, para crianças com maior risco (ver Comentário 19).																		SIM, para RNPT e de risco	SIM

17/06/2026

- Sempre que possível, preferir vacinas combinadas e/ou considerar aplicações simultâneas na mesma visita.
- ESAVI significativos devem ser notificados às autoridades competentes.

Algumas vacinas podem estar especialmente recomendadas para pacientes portadores de comorbidades ou em outra situação especial. Consulte os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais.*

* Vacinas Hepatite B combinadas: Pentavalente de células inteiras, HEXA acelular e Twinrix (hepatite A/B), a partir de 1 ano de idade.

CRIANÇA

COMENTÁRIOS

1. BCG ID: deverá ser aplicada o mais precocemente possível, em recém-nascidos com peso maior ou igual a 2.000 g. Em casos de histórico familiar, suspeita de imunodeficiência ou RNs cujas mães fizeram uso de biológicos durante a gestação, a vacinação poderá ser postergada ou contraindicada (consulte os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais*). A revacinação com BCG não é recomendada mesmo para crianças que não desenvolveram cicatriz vacinal, pela ausência de evidências de que a repetição traga benefício adicional.

Quando solicitado teste de triagem de erros inatos do sistema imune, adiar vacinação até avaliação do resultado.

2. Hepatite B: São 3 doses no total (0,1 e 6 meses). a) Aplicar a primeira dose nas primeiras 12 horas de vida. b) O esquema de quatro doses pode ser adotado quando é utilizada uma vacina combinada que inclua a vacina hepatite B. c) Se mãe HBsAg+, administrar também HBIG o mais precocemente possível (até sete dias após o parto).

3. Vacina rotavírus monovalente: duas doses aos 2 e 4 meses de idade. **Vacina rotavírus pentavalente**: três doses aos 2, 4 e 6 meses de idade. **Para ambas as vacinas**, a primeira dose pode ser feita a partir de 6 semanas de vida. Em caso de recuperação de esquemas de atraso vacinal, a D1 aplicar no máximo até 11 meses e 29 dias, e a última dose até 23 meses e 29 dias (uso off label). Intervalo mínimo entre doses de 30 dias. Se a criança cuspir, regurgitar ou vomitar após a vacinação, não repetir a dose. Se alguma dose na série for RV5 ou desconhecida, aplicar três doses. Não utilizar em crianças hospitalizadas. Em caso de suspeita de imunodeficiência ou RNs cujas mães fizeram uso de biológicos durante a gestação, a vacina pode estar contraindicada e seu uso deve ser avaliado pelo médico (consulte os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais*).

4. Tríplice bacteriana: o uso da vacina acelular (DTPa) é preferível ao de células inteiras (DTPw) pois os eventos adversos associados com a sua administração são menos frequentes e intensos. O reforço dos 4 a 6 anos pode ser feito com DTPa-VIP, dTpa-VIP. O reforço seguinte deverá ser feito com a vacina tríplice acelular do tipo adulto (dTpa), cinco anos após, preferencialmente entre 9 e 11 anos.

5. Hib: recomenda-se o reforço aos 15-18 meses, principalmente quando for utilizada vacina Hib nas formulações combinadas com tríplice bacteriana acelular (DTPa) na série primária. Não é recomendada vacinação de rotina para crianças saudáveis a partir de 5 anos de idade, independente do passado vacinal.

6. Poliomielite: o PNI alterou o esquema da vacina pólio para quatro doses exclusivamente com a vacina inativada (VIP): aos 2, 4, 6 meses e 1 único reforço aos 15 meses de idade. No PNI a VIP poderá ser administrada para crianças menores de 5 anos em atraso com o esquema vacinal. A SBIm continua recomendando o segundo reforço entre 4 e 6 anos de idade, de preferência com a vacina combinada (DTPa + VIP ou dTpa+ VIP).

7. Pneumocócicas conjugadas: a SBIm, com o intuito de ampliar a proteção para sorotipos adicionais, recomenda no esquema básico e no reforço, preferencialmente, as vacinas VPC20 ou VPC15. Independente da VPC utilizada, sempre no esquema 3+1 para os que iniciam até os 6 meses de idade.

Crianças menores de 6 anos com esquema completo ou incompleto de VPC10 se beneficiarão com dose(s) adicional(is) com as vacinas VPC20 ou VPC15. Para proteção adequada contra os sorotipos adicionais, o esquema deve respeitar as recomendações de bula para a idade de início da vacinação.

Crianças saudáveis com esquema completo com a VPC13 não necessitam revacinar com a VPC20 ou VPC15, exceto se forem de maior risco para doença pneumocócica invasiva – DPI, quando está indicada a complementação com a VPC20.

As vacinas VPC20 e VPC15 são intercambiáveis em qualquer momento do esquema vacinal.

O PNI recomenda esquema 2+1 com a PCV20, em um esquema de transição: VPC20 aos 2 meses, VPC10 aos 4 meses e VPC20 aos 12 meses.

Ver Guia Técnico em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/2026/guia-tecnico-para-introducao-da-vacina-pneumococica-20-valente-conjugada-no-programa-nacional-de-imunizacoes.pdf

8. Meningocócicas conjugadas ACWY/C: a SBIm recomenda preferencialmente a vacina MenACWY pela maior abrangência de sorogrupos. O PNI oferece Vacina menC aos 3 e 5 meses e menACWY no reforço aos 12 meses. Diferentes vacinas meningocócicas ACWY estão licenciadas no Brasil e os esquemas e idades de licenciamento variam conforme o fabricante. Crianças vacinadas com MenC podem se beneficiar com o uso da MenACWY e, nesse caso, deve ser respeitado intervalo mínimo de um mês da última dose de MenC. Para proteção adequada dos três sorogrupos adicionais, deve-se adotar o esquema recomendado pelo fabricante para a idade do início, independente da vacinação prévia com MenC. A SBIm recomenda um segundo reforço da vacina MenACWY para crianças entre 5-6 anos de idade (ou cinco anos após a última dose) pela diminuição dos títulos de anticorpos protetores observada após esse período com todas as vacinas meningocócicas conjugadas.

9. Meningocócica B: pode ser usada a partir de 2 meses de idade, idealmente iniciando com uma dose aos 3 meses, outra aos 5 meses e uma dose de reforço entre 12 e 15 meses (esquema 2+1). Crianças de 12 a 23 meses devem receber duas doses com intervalo de dois meses entre elas com uma dose de reforço entre 12 e 23 meses após esquema primário. A partir dos 24 meses de idade: duas doses com intervalo mínimo de um a dois meses entre elas – não foi estabelecida ainda a necessidade de dose(s) de reforço. Em grupos de alto risco para doença meningocócica, consulte os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais*.

10. Influenza: é recomendada para todas as crianças a partir dos 6 meses de idade. Quando administrada pela primeira vez em crianças menores de 9 anos, aplicar duas doses com intervalo de 30 dias. Em crianças com fatores de risco e em situação epidemiológica que justifique, pode ser considerada uma segunda dose, a partir de três meses após a dose anual. A campanha de vacinação nos Estados da Região Norte tem início antecipado em relação às outras regiões do país (entre novembro e fevereiro), coincidindo com a sazonalidade regional. A vacina utilizada tem a formulação recomendada pela OMS para o Hemisfério Norte (HN). A vacina do Hemisfério Sul poderá ser recomendada como dose extra para crianças em situações de risco ou para brasileiros viajantes internacionais ou com destino aos estados do Norte do país. A efetividade vai depender do match (combinação) com as cepas circulantes quando da dose extra.

11. Febre amarela: Duas doses: aos 9 meses e aos 4 anos de idade. Recomendação do PNI: se recebeu a primeira dose antes dos 5 anos de idade, indicada uma segunda dose, independentemente da idade atual; se aplicada a partir dos 5 anos: dose única. Recomendação da SBIm: como há possibilidade de falha vacinal mesmo para quem receber a primeira dose a partir dos 5 anos, a SBIm recomenda uma segunda dose 10 anos após. Contraindicada para imunodeprimidos, mas se o risco de adquirir a doença superar os riscos potenciais da vacinação, o médico deve avaliar seu uso (consulte os Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais). Recomenda-se que crianças menores de 2 anos de idade, sempre que possível, não recebam as vacinas febre amarela e tríplice viral no mesmo dia, respeitando-se um intervalo de 30 dias entre elas. Essa vacina pode ser exigida para maiores de 9 meses de vida para emissão do CIVP, atendendo exigências sanitárias de alguns destinos internacionais. Neste caso, deve ser aplicada até dez dias antes de viajar.

12. Hepatite A: para crianças a partir de 12 meses de idade não vacinadas para hepatite B no primeiro ano de vida, a vacina combinada hepatites A e B na formulação adulto pode ser considerada para substituir a vacinação isolada (A ou B) com esquema de duas doses (0-6 meses).

13. Sarampo, caxumba e rubéola: para crianças com esquema completo, não há evidências que justifiquem uma terceira dose como rotina, podendo ser considerada em situações de risco epidemiológico, como surtos de caxumba e/ou sarampo. Em situação de risco para o sarampo – por exemplo, surto ou exposição domiciliar – a primeira dose deve ser aplicada a partir de 6 meses de idade. Nesses casos, a aplicação de mais duas doses após a idade de 1 ano ainda será necessária. Veja considerações sobre o uso da vacina tetraviral (SCRV) no item 15. O uso em imunodeprimidos deve ser avaliado pelo médico (consulte os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais*).

14. Varicela: é considerada adequadamente vacinada a criança que tenha recebido duas doses da vacina após 1 ano de idade. Em situação de risco – por exemplo, surto de varicela ou exposição domiciliar – a primeira dose pode ser aplicada a partir de 9 meses de idade. Nesses casos, a aplicação de mais duas doses após a idade de 1 ano ainda será necessária. Veja considerações sobre o uso da vacina tetraviral (SCRV) no item 15. O uso em imunodeprimidos deve ser avaliado pelo médico (consulte os *Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais*).

15. Tetraviral (SCRV): aos 12 meses, na mesma visita, aplicar a primeira dose da tríplice viral e varicela em administrações separadas (SCR + V) ou com a vacina tetraviral (SCRV). A segunda dose de tríplice viral e varicela, preferencialmente com vacina tetraviral, pode ser administrada a partir dos 15 meses de idade, mantendo intervalo de três meses da dose anterior de SCR, V ou SCRV.

16. HPV: duas vacinas estão disponíveis no Brasil, HPV4 e HPV9. A SBIm, com o intuito de ampliar a proteção para os tipos adicionais, recomenda, sempre que possível, o uso preferencial da vacina HPV9 em duas doses, assim como a revacinação daqueles anteriormente vacinados com HPV2 ou HPV4. Na impossibilidade do uso de HPV9, a HPV4 deve ser recomendada e está disponível gratuitamente nas UBS para meninas e meninos de 9 a 14 anos em dose única.

- Não vacinados anteriormente: duas doses de HPV9 (0-6 meses);
- Vacinados com uma dose de HPV4:
  - Duas doses de HPV9 (0-6 meses), respeitando o intervalo de seis meses da 1ª dose de HPV4;
  - na falta de HPV4, a aplicação de uma dose de HPV9 é segura, no entanto, completa a proteção apenas para os quatro tipos comuns às duas vacinas, desde que respeitado intervalo de seis meses.
- Completamente vacinados com HPV2 ou HPV4: duas doses (0-6 meses) de HPV9, respeitando intervalo de um ano da última dose de HPV2 ou HPV4.
- O PNI oferece a a vacina HPV4, além da rotina, para determinadas situações de risco: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/h/hpv/publicacoes/esquema-vacinal-hpv

17. Dengue: Qdenga® é recomendada independente de contato prévio com o vírus da dengue em crianças a partir de 4 anos de idade, no esquema de duas doses com intervalo de três meses entre elas (0-3 meses). Para crianças imunodeprimidas ver calendários especiais SBIm. .

18. Covid-19: recomendada pelo PNI para crianças de 6 meses até menores de 5 anos de idade. Esquema de doses dependendo da vacina utilizada. Ver https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/covid-19

19. VSR: existem duas estratégias eficazes para proteção da criança contra infecção pelo VSR, a vacinação da gestante e a administração do anticorpo monoclonal – Nirsevimabe – na criança.

Situações em que o uso de Nirsevimabe está **formalmente recomendado, preferencialmente ainda na maternidade:**

PNI

- Crianças prematuras (<37 de IG), menores de 6 meses de idade. Aplicar em qualquer época do ano, independente da sazonalidade.
- Crianças com comorbidades elegíveis*: administrar durante as sazonalidades (de fevereiro a agosto), a partir do nascimento e até antes de completar 24 meses de idade (1 ano, 11 meses e 29 dias).

SBIm

Aplicar em qualquer época do ano, independente da sazonalidade, em todas as situações abaixo.

- RN de mães **não** vacinadas;
- RN de mães imunossuprimidas, mesmo vacinadas durante a gestação;
- Parto ocorrido antes de 14 dias da vacinação materna;
- Bebês nascidos prematuros (< 37 semanas de IG), com menos de 12 meses de idade (11 meses e 29 dias);
- Crianças com idade inferior a 24 meses (até 1 ano, 11 meses e 29 dias) com comorbidades elegíveis*.

*Lista de comorbidades elegíveis: doença pulmonar crônica da prematuridade, doença cardíaca congênita hemodinamicamente significativa, imunocomprometidos, Síndrome de Down, fibrose cística, doença neuromuscular e anomalias congênitas das vias aéreas.

Esquemas:

- Crianças <12 meses de idade
  - uma dose IM de 50 mg se peso < 5 Kg
  - uma dose de 100mg se peso ≥5 Kg
- Crianças de 12-23 meses de idade e com risco para infecção grave por VSR:
  - 200 mg (duas doses de 100mg administradas simultaneamente), independente de peso.

A SBIm também orienta que **pode ser considerado** seu uso nas seguintes situações, independentemente da vacinação materna, em **decisão compartilhada entre família e pediatra**:

- Uma nova dose de Nirsevimabe para prematuros menores de 12 meses de idade se a primeira dose foi aplicada há mais de 6 meses, a depender de risco epidemiológico e individual.
- Crianças <12 meses, nascidas a termo, sem fatores de risco, ou seja, sem comorbidades, a depender de risco epidemiológico e individual.
- Crianças de 12 a < 24 meses (até 1 ano, 11 meses e 29 dias) **sem fatores de risco** também podem se beneficiar, a depender de risco epidemiológico e individual. Nesse caso a SBIm sugere:
  - uma dose IM de 100 mg se peso < 10 Kg.
  - 200 mg (duas doses de 100mg administradas simultaneamente) se peso ≥10 Kg.

Pode ser coadministrado com as demais vacinas recomendadas no Calendário de Vacinação SBIm do Prematuro e da Criança.

Este medicamento está no rol da ANS, com cobertura pelos planos/ convênios de saúde, para:

- prematuros com idade gestacional < 37 e com idade inferior a 6 meses.
- crianças com idade inferior a 2 anos com pelo menos uma das comorbidades listadas anteriormente.

Vacinas combinadas pertussis	Composição vacinal					
	Difteria	Tétano	Coqueluche	Hib	Hepatite B	Poliomielite
Tríplice bacteriana infantil de células inteiras (DTPw)	x	x	Células inteiras	–	–	–
Pentavalente de células inteiras (DTPw-HB-Hib)	x	x	Células inteiras	x	x	–
Pentavalente acelular (DTPa-VIP-Hib)	x	x	Acelular	x	–	x
Hexavalente acelular (DTPa-HB-VIP-Hib)	x	x	Acelular	x	x	x
Tetravalente pediátrica acelular (DTPa-VIP)	x	x	Acelular	–	–	x
Tríplice bacteriana adulto acelular (dTpa)	x	x	Acelular	–	–	–
Tetravalente adulto acelular (dTpa-VIP)	x	x	Acelular	–	–	x

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO SBIm OCUPACIONAL

Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2026/2027

Os comentários numerados devem ser consultados.

Este calendário considera as vacinas particularmente recomendadas para prevenir doenças infecciosas relacionadas ao risco ocupacional para o trabalhador e/ou sua clientela.

Vacinas especialmente indicadas	*Todo indivíduo deve estar em dia com o calendário recomendado para sua faixa etária e condição clínica. Na impossibilidade de cumpri-lo integralmente, devem-se considerar, no mínimo, as vacinas disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais (RIE).** **Esquemas e recomendações**	Indicações especiais por área de atuação														
		Saúde	Alimentos e bebidas	Forças de salvamento	Exposição a lixo e águas contaminadas	Serviços prestados a crianças	Serviços com exposição a animais	Serviços sexuais	Serviços administrativos	Viajantes frequentes	Receptivo de estrangeiros e turismo	Beleza e bem-estar	Atuação profissional em ambientes fechados de uso coletivo	Missões e ajuda humanitária	Esporte profissional	Cuidados a indivíduos em condições de vulnerabilidade
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) [1]	• **Para não vacinados:** duas doses com intervalo de um mês. • **Com uma dose**: fazer a segunda dose. • **Com esquema completo** (duas doses após 12 meses de idade): não há evidências que justifiquem uma terceira dose como rotina, podendo ser considerada em situações de risco epidemiológico, como surtos de caxumba e/ou sarampo.	SIM	SIM	SIM	–	SIM	–	SIM	–	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Hepatites A, B ou A e B [3]	**Hepatite A:** duas doses, no esquema 0-6 meses.	SIM [5]	SIM	SIM	SIM	SIM	–	SIM	–	SIM	SIM	–	SIM	SIM	SIM	SIM [10]
	Hepatite B [2]: três doses, no esquema 0-1-6 meses.	SIM	–	SIM	SIM	–	–	SIM	–	SIM	–	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
	Hepatite A e B: três doses, no esquema 0-1-6 meses. A vacina combinada é uma opção e pode substituir a vacinação isolada das hepatites A e B.	SIM [5]	–	SIM	SIM	–	–	SIM	–	SIM	–	–	SIM	SIM	SIM	SIM
HPV	• 16 a 19 anos: duas doses, no esquema 0-6 meses. • ≥ 20 anos: três doses, no esquema 0-2-6 meses.	–	–	–	–	–	–	SIM	–	–	–	–	–	–	–	–
Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (difteria, tétano e coqueluche) – dTpa ou dTpa-VIP Dupla adulto (difteria e tétano) – dT	• Atualizar dTpa com intervalo mínimo de quatro semanas de dose anterior de dT ou TT. ◦ **Com esquema de vacinação básico completo:** reforço com dTpa dez anos após a última dose. ◦ **Com esquema de vacinação básico incompleto:** uma dose de dTpa a qualquer momento e completar a vacinação básica com uma ou duas doses de dT de forma a totalizar três doses de vacina contendo o componente tetânico. ◦ **Não vacinados e/ou histórico vacinal desconhecido:** uma dose de dTpa e duas doses de dT no esquema 0-2-4 a 8 meses. • A dTpa pode ser substituída por dTpa-VIP ou dT, dependendo da disponibilidade.	dTpa	dT	dT ou dTpa-VIP [7]	dT	dTpa	dT	–	–	dTpa-VIP [6]	dTpa	dT	dTpa	dTpa-VIP [7]	dT ou dTpa-VIP [6]	dTpa ou dTpa-VIP
Poliomielite inativada [6]	• Uma dose. • Ver recomendações em *https://sbim.org.br/images/files/notas-tecnicas/nota-informativa-cgpni-vacinacao-viajantes-polio-2112.pdf*	–	–	SIM [7]	–	–	–	–	–	SIM [6]	–	–	–	SIM [7]	–	–
Varicela (catapora) [1]	**Para suscetíveis:** duas doses com intervalo de um a dois meses.	SIM	–	SIM [7]	–	SIM	–	SIM	–	SIM [7]	SIM	–	SIM	SIM	SIM	SIM
Influenza (gripe) [8]	• Dose única anual. • Em idosos, imunodeprimidos e em situação epidemiológica de risco, pode ser considerada uma segunda dose, a partir de 3 meses após a dose anual. • Se a composição da vacina disponível for concordante com os vírus circulantes, poderá ser recomendada aos viajantes internacionais para o hemisfério norte e/ou brasileiros residentes nos estados do norte do país no período pré-temporada de influenza. • Para trabalhadores com idade superior a 60 anos, optar preferencialmente pela vacina de alta concentração (*high dose*).	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Meningocócica conjugada ACWY	Uma dose. A indicação da vacina, assim como a necessidade de reforços, dependerão da situação epidemiológica e situação clínica do trabalhador.	SIM [5]	–	SIM [7]	–	–	–	–	–	SIM [7]	–	–	–	SIM [7]	SIM [9]	–
Meningocócica B	Duas doses com intervalo mínimo de um mês. Considerar seu uso avaliando a situação epidemiológica e situação clínica do trabalhador.	SIM [5]	–	SIM [7]	–	–	–	–	–	SIM [7]	–	–	–	SIM [7]	SIM [9]	–
Febre amarela [1]	• **Recomendação do PNI:** se recebeu a primeira dose antes dos 5 anos de idade, indicada uma segunda dose. Se aplicada a partir dos 5 anos: dose única. • **Recomendação da SBIm:** Duas doses. Como há possibilidade de falha vacinal, está recomendada uma segunda dose com intervalo de 10 anos. • Essa vacina pode ser exigida para emissão do CIVP, atendendo exigências sanitárias de alguns destinos internacionais. Neste caso, deve ser aplicada até dez dias antes de viajar.	–	–	SIM	–	–	–	–	–	SIM	–	–	–	SIM	–	–
Dengue [1]	Vacina Takeda: duas doses, 0-3 meses.	SIM	–	SIM	–	–	–	–	–	SIM	SIM	–	–	SIM	SIM	–
Raiva [4]	**Para pré-exposição:** duas doses, 0-7 dias.	–	–	SIM [7]	–	–	SIM	–	–	–	–	–	–	SIM [7]	–	–
Covid-19	Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em *https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/covid-19/notas-tecnicas*															

19/06/2026 • Sempre que possível, preferir vacinas combinadas. • Sempre que possível, considerar aplicações simultâneas na mesma visita. • Qualquer dose não administrada na idade recomendada deve ser aplicada na visita subsequente. • Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação ou Imunização (ESAVI) significativos devem ser notificados às autoridades competentes.

* A disponibilidade das vacinas nas redes pública e privada pode ser verificada nos *Calendários de vacinação SBIm*: https://sbim.org.br/calendario-de-vacinacao e https://sbim.org.br/calendario-de-vacinacao/pacientes-especiais

Saúde: médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, patologistas e técnicos de patologia, dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, pessoal de apoio, manutenção e limpeza de ambientes hospitalares, maqueiros, motoristas de ambulância, técnicos de RX, agentes comunitários de saúde e de endemias e outros profissionais lotados ou que frequentam assiduamente os serviços de saúde, tais como representantes da indústria farmacêutica e outros.

Alimentos e bebidas: profissionais que trabalham em empresas de alimentos e bebidas, cozinheiros, garçons, pessoal de apoio, manutenção e limpeza.

Forças de salvamento: militares, policiais e bombeiros, especificamente para aqueles que atuam em missões em regiões com riscos epidemiológicos e possibilidade de surtos por doenças imunopreveníveis.

Exposição a águas contaminadas e lixo: mergulhadores, salva-vidas, guardiões de piscinas, manipuladores de lixo e/ou esgotos e/ou águas pluviais, alguns profissionais da construção civil.

Serviços prestados à crianças: professores e outros profissionais que trabalham em escolas, creches e orfanatos, ou no cuidado domiciliar de crianças menores de 2 anos.

Serviços com exposição a animais: veterinários e outros profissionais que lidam com animais, frequentadores ou visitantes de cavernas.

Serviços sexuais: risco para as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e outras doenças infecciosas de transmissão por contato interpessoal, por via aérea ou secreções.

Serviços administrativos: trabalhadores em escritórios, fábricas e outros ambientes geralmente fechados.

Viajantes Frequentes: risco aumentado de exposição a infecções endêmicas e surtos em destinos nacionais ou internacionais.

Receptivo de estrangeiros e turismo: operadores e guias de turismo, profissionais da hotelaria; transporte público, seguranças de estabelecimentos como estádios, ginásios, boates, entre outros.

Beleza e bem-estar: manicures, pedicures, podólogos e tatuadores.

Atuação profissional em ambientes fechados de uso coletivo: agentes penitenciários e carcerários, trabalhadores de instituições de longa permanência, orfanatos e hospitais psiquiátricos, trabalhadores de plataformas marítimas.

Missões e ajuda humanitária: risco de exposição a doenças endêmicas, condições de trabalho insalubre, risco aumentado para transmissão de doenças infecciosas.

Esporte profissional: recebem alto investimento e têm obrigação de apresentar resultados; vivem situações de confinamento e viajam frequentemente; passam por fases de treinamento intenso com prejuízo da resposta imunológica; esportes coletivos facilitam a transmissão interpessoal de doenças, com maior risco para surtos.

Cuidados a indivíduos em condições de vulnerabilidade: crianças menores de 12 meses, idosos, pessoas com comorbidades, imunodeprimidas e/ou portadoras de outras deficiências.

COMENTÁRIOS

Vacinas disponíveis nas UBS e RIE: ver disponibilidades nos calendário de vacinação do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

1. Vacinas vivas atenuadas são contraindicadas para gestantes e/ou pessoas com imunodepressão por doença e/ou tratamento. Em vigência de imunossupressão grave, as vacinas febre amarela, SCR, varicela, SCR-V e dengue estão formalmente contraindicadas. Se paciente leve ou moderadamente imunocomprometido, o médico deverá avaliar parâmetros clínicos e risco epidemiológico para recomendação de vacinas vivas atenuadas.

Para pessoas que apresentam contraindicação à Vacina Febre Amarela e necessitam do Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP) de febre amarela, o atestado de isenção, disponível no site da ANVISA, deverá ser emitido pelo médico assistente. Para maiores informações, consulte os *Calendários SBIm Pacientes Especiais* no link *https://sbim.org.br/calendario-de-vacinacao/ocupacional*.

2. Hepatite B não está mais disponível na forma isolada na rede privada para adultos (≥ 20 anos). Em situações de recomendação das vacinadas hepatite A e B, a vacina combinada HAHB poderá ser recomendada.

3. Sorologia 30 a 60 dias após a terceira dose da vacina é recomendada para: profissionais da saúde, imunodeprimidos e renais crônicos. Considera-se imunizado o indivíduo que apresentar título anti-HBs ≥ 10 UI/mL.

4. A partir do 14º dia após a última dose verificar títulos de anticorpos com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de dose adicional. Profissionais que permanecem em risco devem fazer acompanhamento sorológico a cada seis meses ou um ano, e receber dose de reforço quando os títulos forem menores que 0,5 UI/mL.

5. Em relação à vacinação de profissionais lotados em serviços de saúde, a vacina hepatite A está especialmente indicada para profissionais da lavanderia, da cozinha e manipuladores de alimentos e de dejetos fecais; as vacinas meningocócicas ACWY e B estão indicadas para profissionais da saúde da bacteriologia ou que exercem ajuda humanitária/situações de catástrofes.

6. Recomendada para profissionais com destino a países nos quais a poliomielite seja endêmica e/ou haja risco de exportação do vírus selvagem. A vacina disponível na rede privada é combinada à dTpa (dTpa-VIP).

7. Indicada para aqueles que atuam em missões ou em outras situações com possibilidade de surtos, conforme a avaliação do risco epidemiológico.

8. Embora algumas categorias profissionais não apresentem risco ocupacional aumentado para influenza, a indicação para TODAS as áreas de atuação é justificada pela possibilidade de desencadeamento de surtos no ambiente de trabalho, absenteísmo e presenteísmo.

9. Considerar para aqueles que viajam para competições e atividades esportivas em áreas de risco.

10. Em relação à vacinação de cuidadores: vacina hepatite A para os que acompanham pessoas em situação de vulnerabilidade, com maior risco para complicações.

Atualizado em 19.06.2026

Esta publicação foi composta com a família da fonte Frutiger.
Versão digital 19/06/2026

Realização:

SBIm
Sociedade Brasileira de Imunizações

Calendários SBIm

Conteúdo de responsabilidade exclusiva da SBIm. MAGIC|RM v. digital 19.06.2026

Chamamos de **funcionalidade** a combinação de todas as capacidades físicas e mentais, interagindo com o ambiente em que você vive e que permite que você seja ou faça o que considera importante. A **autonomia** é a capacidade de tomar decisões adequadas e gerir a própria vida. A **independência** é a capacidade de executar as ações e as atividades de vida diária que são importantes para você.

Para refletir!

Para mim, o envelhecimento saudável representa:

FORTALEÇA A RELAÇÃO COM A EQUIPE DE SAÚDE DE REFERÊNCIA.

Construa uma relação de confiança e diálogo aberto com sua equipe de saúde de referência. O vínculo gerado ao longo do tempo permite melhor avaliação, diagnóstico e tratamento. Mesmo que faça acompanhamento com mais de um profissional ou serviço de saúde, mantenha seu acompanhamento na sua UBS de referência, responsável por organizar e coordenar o seu cuidado no Sistema de Saúde.

UM POUCO SOBRE MIM: AFETOS E SIGNIFICADO

Escreva aqui sobre aspectos importantes de sua história de vida; sobre o que te faz bem, suas preferências, desejos ou vivências que carregam importante significado para você.

QUEM ESTÁ PREENCHENDO ESSE QUESTIONÁRIO?			
☐ Pessoa idosa ☐ Amigo(a)/familiar ☐ Profissional de saúde			
1	Eu sofri quedas no ano passado.	☐ SIM	☐ NÃO
2	Fui aconselhado(a) a usar bengala ou andador para me locomover.	☐ SIM	☐ NÃO
3	Às vezes, eu me sinto instável ao andar.	☐ SIM	☐ NÃO
4	Quando ando pela casa, seguro nos móveis.	☐ SIM	☐ NÃO
5	Estou preocupado(a) com as quedas.	☐ SIM	☐ NÃO
6	Preciso apoiar com as mãos para me levantar de uma cadeira.	☐ SIM	☐ NÃO
7	Tenho dificuldade para subir no meio-fio.	☐ SIM	☐ NÃO
8	Muitas vezes, tenho que sair depressa para o banheiro.	☐ SIM	☐ NÃO
9	Perdi um pouco de sensibilidade nos pés.	☐ SIM	☐ NÃO
10	Tomo remédios que às vezes me fazem sentir tonto(a) ou cansado(a).	☐ SIM	☐ NÃO
11	Tomo remédios para dormir ou para melhorar o humor.	☐ SIM	☐ NÃO
12	Muitas vezes eu me sinto triste ou deprimido(a).	☐ SIM	☐ NÃO

Check-up para prevenção de quedas, traduzido e adaptado de *CDC's National Center for Injury Prevention and Control e NCOA Center for Healthy Aging.*



Vacina sempre Brasil

VACINAÇÃO

Uma das formas mais simples e eficazes de cuidar da saúde é **mantendo suas vacinas em dia!**

Você sabia que existe um calendário de vacinação para pessoas com 60 anos ou mais? Ele é coordenado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), que garante **vacinas gratuitas e seguras para todos os brasileiros** no SUS.

Clique aqui

SAIBA MAIS!

Sobre as principais vacinas recomendadas para as pessoas idosas — e como elas ajudam a manter sua saúde protegida — no site do Ministério da Saúde.

Mantenha as suas vacinas sempre em dia: esse é um compromisso com a nossa saúde e com a de todas as pessoas ao nosso redor.

Procure a **UBS** mais próxima de sua casa.

Leve esta Caderneta e todos os outros cartões de vacinação que tiver.

As vacinas são seguras e importantes em todas as idades. Vacine-se!

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E CUIDADOS COM MEDICAMENTOS

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

O SUS oferece medicamentos gratuitos para o tratamento das principais doenças existentes na população brasileira.

Consulte, na *Relação Nacional de Medicamentos Essenciais* (Rename), a lista completa de medicamentos padronizados disponibilizados.

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais

Clique aqui

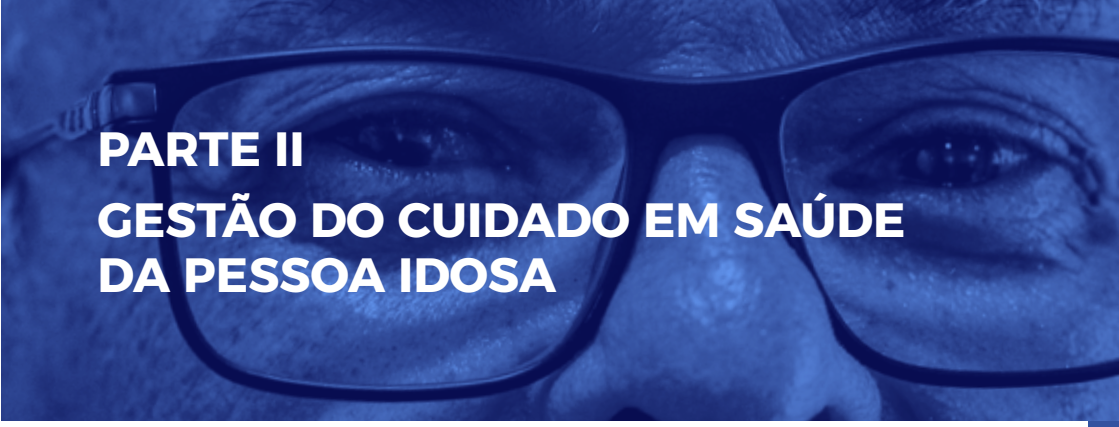
Pergunta	Sim	Não	Às vezes
Você tem dificuldade para abrir ou fechar embalagens?	☐	☐	☐
Você tem dificuldade para ler o que está escrito na embalagem?	☐	☐	☐
Você tem dificuldades para lembrar de tomar o medicamento?	☐	☐	☐
Você tem dificuldades para tomar vários comprimidos de uma vez?	☐	☐	☐
Você tem dificuldades para conseguir os medicamentos no tempo certo?	☐	☐	☐
Você costuma mudar a forma como usa os medicamentos sem orientação médica?	☐	☐	☐

Atenção!
É fundamental seguir corretamente a indicação do tratamento. Caso perceba efeitos adversos, sintomas desconfortáveis ou considere que algum ajuste pode ser necessário, **informe o profissional de saúde responsável pela prescrição ou busque sua equipe de saúde de referência.**

PARA LEMBRAR DE FALAR COM MINHA EQUIPE DE SAÚDE

Anote na tabela da próxima página situações importantes sobre sua saúde, que você gostaria de levar para sua equipe na próxima consulta. Anote, por exemplo, se apresentar algum mal-estar incomum, tontura ou desequilíbrio, crises de dor, problemas com o sono, engasgos ou vômitos, pintas ou machucados na pele que não desaparecem, nódulos ou ínguas, esquecimentos, confusão, desorientação, convulsão, entre outros.

Para falar com o profissional de saúde na próxima consulta			
Data	**O que aconteceu?**	**O que foi feito para melhorar?**	**Outras observações**



PARTE II
GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE DA PESSOA IDOSA

As páginas a seguir, sinalizadas com a cor azul, são direcionadas ao registro dos(as) **profissionais de saúde** que te acompanham.

ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE

Devem ser registradas informações sobre o **histórico de saúde, como condições clínicas, diagnósticos, cirurgias, internações, eventos adversos e outras ocorrências relevantes.**

DATA	CONDIÇÕES	OBSERVAÇÃO

DATA	CONDIÇÕES	OBSERVAÇÃO

MEDICAMENTOS EM USO

NOME DO MEDICAMENTO E CONCENTRAÇÃO	DOSE E FREQUÊNCIA	INDICAÇÃO	INICIADO EM	DESPRESCRIÇÃO	
				DATA	MOTIVO

AVALIAÇÃO CLÍNICA

HISTÓRICO DE CONSULTAS					
DATA DO ATENDIMENTO		___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____
ACOMPANHANTE NA CONSULTA					
QUEIXA / DEMANDA					
COGNIÇÃO					
HUMOR / COMPORTAMENTO					
MOBILIDADE / MARCHA					
ESCORE DE RISCO IVCF-20[1]					
PERÍMETRO DA PANTURRILHA[2]					
DADOS ANTROPOMÉTRICOS	PESO				
	ALTURA				
	IMC				
PRESSÃO ARTERIAL	DEITADO(A)				
	SENTADO(A)				
	EM PÉ				

1 - PONTUAÇÃO IVCF-20 OU OUTROS INSTRUMENTOS SIMILARES.
2 - É UM BOM PARÂMETRO DE AVALIAÇÃO DA MASSA MUSCULAR NA PESSOA IDOSA. MEDIDA < 31 CM SUGERE REDUÇÃO NA MASSA MUSCULAR (SARCOPENIA).

HISTÓRICO DE CONSULTAS					
DATA DO ATENDIMENTO		___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____
ACOMPANHANTE NA CONSULTA					
QUEIXA / DEMANDA					
COGNIÇÃO					
HUMOR / COMPORTAMENTO					
MOBILIDADE / MARCHA					
ESCORE DE RISCO IVCF-20[1]					
PERÍMETRO DA PANTURRILHA[2]					
DADOS ANTROPOMÉTRICOS	PESO				
	ALTURA				
	IMC				
PRESSÃO ARTERIAL	DEITADO(A)				
	SENTADO(A)				
	EM PÉ				

1 - PONTUAÇÃO IVCF-20 OU OUTROS INSTRUMENTOS SIMILARES.
2 - É UM BOM PARÂMETRO DE AVALIAÇÃO DA MASSA MUSCULAR NA PESSOA IDOSA. MEDIDA < 31 CM SUGERE REDUÇÃO NA MASSA MUSCULAR (SARCOPENIA).

HISTÓRICO DE CONSULTAS					
DATA DO ATENDIMENTO		___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____
ACOMPANHANTE NA CONSULTA					
QUEIXA / DEMANDA					
COGNIÇÃO					
HUMOR / COMPORTAMENTO					
MOBILIDADE / MARCHA					
ESCORE DE RISCO IVCF-20[1]					
PERÍMETRO DA PANTURRILHA[2]					
DADOS ANTROPOMÉTRICOS	PESO				
	ALTURA				
	IMC				
PRESSÃO ARTERIAL	DEITADO(A)				
	SENTADO(A)				
	EM PÉ				

1 - PONTUAÇÃO IVCF-20 OU OUTROS INSTRUMENTOS SIMILARES.
2 - É UM BOM PARÂMETRO DE AVALIAÇÃO DA MASSA MUSCULAR NA PESSOA IDOSA. MEDIDA < 31 CM SUGERE REDUÇÃO NA MASSA MUSCULAR (SARCOPENIA).

OUTROS TESTES COMPLEMENTARES – AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL

AVALIAÇÃO DE RISCOS INDIVIDUAIS PARA A SAÚDE

Esteja atento(a): a presença de qualquer um desses fatores exige avaliação cuidadosa, definição de condutas e monitoramento pela equipe de saúde.

DATA DA AVALIAÇÃO:						
Está fumante?	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
Faz uso de álcool?	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
Está restrito ao leito (acamado)?	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
Está restrito ao domicílio (domiciliado)?	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
Apresenta feridas crônicas ou lesões de pele (ex: úlcera por pressão)?	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
Apresenta sinais de desidratação?	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
Apresenta sinais de desnutrição?	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
Apresenta dificuldades para engolir (engasgos frequentes)?	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO

AVALIAÇÃO DO SONO

DATA:						
Horas de sono por noite / Média de despertares por noite						
Sente-se cansado como se não tivesse dormido?	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
Deixa de fazer atividades pela manhã por sensação de cansaço	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
Seu sono impacta no sono de outras pessoas (cônjuges / cuidadores(as)?	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO

AVALIAÇÃO AMBIENTAL

Esteja atento(a) à segurança do domicílio, pois a maioria das quedas ocorre dentro de casa.

DATA DA AVALIAÇÃO:						
Áreas com circulação livre de obstáculos						
Presença de barras de apoio	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
Pisos uniformes e tapetes bem fixos	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
Iluminação						
Presença de iluminação suficiente para clarear todo o interior de cada cômodo, incluindo degraus	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
Interruptores acessíveis na entrada dos cômodos	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
Banheiro						
Área do chuveiro com antiderrapante	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
Presença de box com abertura fácil	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
Cozinha e quarto						
Armários na altura adequada ao alcance das mãos	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
Escada ■ Não há						
Piso antiderrapante	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
Corrimão bem posicionado, firme e de ambos os lados	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO

AVALIAÇÃO DO SUPORTE SOCIOFAMILIAR

DATA DA AVALIAÇÃO:						
SUPORTE FAMILIAR						
Mora sozinho	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
Residente em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), abrigos, casa-lar, ou outras formas de moradias coletivas	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
Presença de companheiro(a) ou cônjuge	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
Viuvez recente, no último ano	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
Presença de alguém com disponibilidade para atendê-lo(a), em caso de necessidade ou presença de cuidador, familiar ou profissional qualificado para a prestação do cuidado necessário	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
Você recebe visitas dos seus familiares ou amigos com regularidade?	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
Responsável pelo cuidado de pessoas dependentes na sua casa	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO